Mälardalens universitet
Institutionen för hälsovetenskap, innovation och design

ATT MOTVERKA OFRIVILLIG ENSAMHET GENOM SOCIAL GEMENSKAP

En kvalitativ studie om personalens uppfattningar av arbetet vid mötesplatser för äldre

ELIAS LÅNG

Huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad nivå
Högskolepoäng: 30 hp
Program: Magisterprogram i folkhälsovetenskap
Kursnamn: Examensarbete i folkhälsovetenskap
Kurskod: FHA043

Handledare: Maria Norfjord van Zyl
Examinator: Thomas Ljung

Seminariedatum: 2026-06-02
Betygsdatum: 2026-06-09

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Ofrivillig ensamhet bland äldre är en folkhälsoutmaning som kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt. Mötesplatser för äldre utgör en viktig arena för att främja social gemenskap och förebygga social isolering. Dock är kunskapen om hur personal uppfattar arbetet med detta begränsad.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap.

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semistrukturerade individuella intervjuer med åtta informanter verksamma vid kommunala mötesplatser för äldre inom två kommuner. Urvalet var målinriktat och materialet analyserades med en manifest innehållsanalys.

Resultat: Studiens resultat består av två huvudkategorier. Den första huvudkategorin, *att skapa social interaktion och delaktighet*, visar att mötesplatser för äldre kan främja social gemenskap genom inkluderande arbete och möjligheter till delaktighet, samtidigt som social osäkerhet kan utgöra hinder för deltagande. Den andra huvudkategorin, *tillgång till olika resurser*, belyser betydelsen av personalens stöd och relationsskapande arbete, men även utmaningar såsom fysisk och psykisk ohälsa samt svårigheter att nå de mest isolerade äldre.

Slutsats: Mötesplatser för äldre framstod som betydelsefulla för att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet. Personalens stöd och relationsskapande arbete var centralt, samtidigt som psykisk och fysisk ohälsa kunde försvåra deltagande. Utifrån Antonovskys KASAM kan mötesplatserna förstås bidra till ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet genom struktur, stöd och social delaktighet.

*Nyckelord***:** Folkhälsovetenskap, kvalitativ ansats, mötesplatser för äldre, ofrivillig ensamhet, social gemenskap

ABSTRACT

Background: Involuntary loneliness among older adults is a public health challenge that can negatively affect both mental and physical health. Meeting places for older adults constitute an important arena for promoting social connectedness and preventing social isolation. However, knowledge about how staff perceive this work remains limited.

Aim: The aim of this study is to explore how staff at meeting places for older adults perceive the work regarding involuntary loneliness and social connectedness.

Method: The study was conducted using a qualitative approach and semi-structured individual interviews with eight informants working at municipal meeting places for older adults in two municipalities. A purposive sampling strategy was used, and the data were analysed using manifest content analysis.

Result: The study findings consist of two main categories. The first category, *creating social interaction and participation*, shows that meeting places for older adults can promote social connectedness through inclusive practices and opportunities for participation, while uncertainty in social situations may constitute a barrier to engagement. The second category, *access to different resources,* highlights the importance of staff support and relationship-building efforts, as well as challenges such as mental and physical health problems and difficulties in reaching the most socially isolated older adults.

Conclusion: Meeting places for older adults appeared to play an important role in promoting social connectedness and reducing involuntary loneliness. Staff support and relationship-building efforts were identified as central, while poor mental and physical health could hinder participation. Based on Antonovsky's Sense of Coherence (SOC) theory, meeting places can be understood as contributing to increased comprehensibility, manageability, and meaningfulness through structure, support, and social participation.

*Keywords***:** Involuntary loneliness, meeting places for older adults, public health science, qualitative approach, social connectedness

INNEHÅLL

1 INLEDNING 1

2 BAKGRUND 2

2.1 Ensamhet och liknande begrepp 2

2.2 Ofrivillig ensamhet som ett folkhälsoproblem 2

2.3 Ofrivillig ensamhet hos äldre 3

2.4 Insatser kopplat till social gemenskap och minskad ofrivillig ensamhet i Sverige 4

2.4.1 Nationell nivå 4

2.4.2 Regional nivå 5

2.4.3 Kommunal nivå 5

2.5 Teoretiskt perspektiv 6

2.6 Problemformulering 6

3 SYFTE 7

4 METOD 7

4.1 Urval 7

4.2 Datainsamling 8

4.3 Analysmetod 9

4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden 11

5 RESULTAT 12

5.1 Skapa social interaktion och delaktighet 12

5.1.1 Möjliggörande av social gemenskap 12

5.1.2 Anpassning av aktiviteter 14

5.2 Tillgång till olika resurser 15

5.2.1 Personalens engagemang 15

5.2.2 Kunskapskrävande arbete 16

5.2.3 Fysiska och mentala förmågor 17

6 DISKUSSION 18

6.1 Resultatdiskussion 18

6.1.1 Vikten av att skapa social interaktion och delaktighet 18

6.1.2 Betydelsen av tillgång till olika resurser i arbetet mot ofrivillig ensamhet 21

6.1.3 Framtida forskning 23

6.1.4 Studiens folkhälsovetenskapliga relevans 25

6.2 Metoddiskussion 25

6.2.1 Urval 25

6.2.2 Datainsamling 26

6.2.3 Analysmetod 27

6.2.4 Kvalitetskriterier 28

6.3 Forskningsetisk diskussion 30

7 SLUTSATSER. 31

REFERENSLISTA 32

BILAGA A; INFORMATIONSBREV

BILAGA B; INTERVJUGUIDE

1 INLEDNING

Ofrivillig ensamhet, en subjektiv upplevelse av brist på önskade sociala relationer (De Jong Gierveld, 1987), har under de senaste åren uppmärksammats som ett växande folkhälsoproblem, både nationellt och internationellt.

Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är ofrivillig ensamhet särskilt problematisk då den är kopplad till en ökad risk för både psykisk och fysisk ohälsa, inklusive depression, ångest och förtida död (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2024). Äldre personer utgör en särskilt sårbar grupp, där faktorer såsom förlust av närstående, minskat socialt nätverk och försämrad hälsa kan bidra till ökad risk för ensamhet (Folkhälsomyndigheten, 2024; Domènech-Abella et al., 2017).

I Sverige bedrivs ett omfattande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet, där både offentliga aktörer och civilsamhället spelar en viktig roll. En central del av detta arbete utgörs av mötesplatser för äldre, vilka syftar till att främja social gemenskap, delaktighet och välbefinnande (Västerås stad, u.å). Trots detta finns det utmaningar i att nå de mest utsatta grupperna där det ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv aktualiserar frågor om jämlik hälsa, då de individer som har störst behov av socialt stöd inte nödvändigtvis är de som lättast nås av befintliga insatser. Kunskapen om hur personalen upplever att verksamheten fungerar i praktiken är fortsatt begränsad. Eftersom personalen arbetar nära målgruppen och dagligen möter både möjligheter och utmaningar i verksamheten kan deras erfarenheter bidra med värdefull kunskap om vilka faktorer som främjar respektive försvårar arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet.

Valet av ämne grundar sig i ett personligt och akademiskt intresse för folkhälsa och äldre personers välbefinnande. Med en tidigare kandidatexamen i folkhälsovetenskap har ett intresse väckts för frågor som berör hälsa, sociala bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete. Samtidigt upplevdes att frågor kopplade till ofrivillig ensamhet bland äldre och mötesplatser för äldre inte gavs något större utrymme under utbildningen, vilket väckte en nyfikenhet att fördjupa kunskapen inom området. Intresset har även stärkts genom personliga erfarenheter, då en närstående beskrivit mötesplatser för äldre som en betydelsefull del av vardagen och delat positiva erfarenheter av verksamheten. Detta har bidragit till ett ökat intresse för att undersöka vilken roll dessa mötesplatser kan ha i arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

2 BAKGRUND

Bakgrunden inleds med en övergripande redogörelse för begrepp relaterade till ensamhet för att sedan koppla dem till äldre som målgrupp. Därefter beskrivs studiens teoretiska perspektiv samt problemformulering.

2.1 Ensamhet och liknande begrepp

Här är vanligt förekommande begrepp som nämns i litteratur i samband med ensamhet. I detta arbete används främst begreppet ofrivillig ensamhet, men övriga termer förekommer också.

Ensamhet är i denna studie definierad enligt De Jong Gierveld (1987) som innebär att ensamheten är ofrivillig, då den baseras på en ouppfylld önskan om social kontakt. Definitionen används ofta i europeiska länder och formuleras som en situation som upplevs av individen som obehaglig eller oacceptabel gällande brist på kvaliteten i vissa relationer. Detta innefattar situationer där antalet befintliga relationer är färre än vad som upplevs som önskvärt eller acceptabelt, samt situationer där den grad av närhet som eftersträvas inte uppnås (De Jong Gierveld, 1987).

Social isolering beskrivs av Nicholson (2012) som ett tillstånd där individen saknar en känsla av social tillhörighet, har bristande engagemang i relation till andra, har ett begränsat antal sociala kontakter samt saknar tillfredsställande och kvalitativa relationer.

Mah et al. (2023) beskriver social sårbarhet som en situation där ogynnsamma sociala förhållanden, såsom låg socioekonomisk status, ökar individens utsatthet för negativa händelser eller hälsorelaterade konsekvenser.

2.2 Ofrivillig ensamhet som ett folkhälsoproblem

Forskning visar att ensamhet och närliggande fenomen, såsom social isolering och social sårbarhet, kan ha betydande konsekvenser för individers hälsa och välbefinnande (Nicholson, 2012; Mah et al., 2023). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2024) beskriver att ofrivillig ensamhet kan innebära en ökad risk för depression, ångest, självmordstankar och förtidig död. Ofrivillig ensamhet är enligt Folkhälsomyndigheten (2025) ett folkhälsoproblem som är ojämlikt fördelad, där förekomsten i många fall är högre i vissa delar av befolkningen, som exempelvis bland yngre och äldre, pensionärer och bland personer med funktionsnedsättning.

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver i en rapport att 16 procent av världens population mellan 2014–2023 uppgav att de kände sig ensamma. Regeringskansliet (2025) fastslår att det i ett globalt perspektiv uppskattas vara över 870 000 dödsfall årligen kopplade till social isolering och ensamhet. Chawla et al. (2021) fann i en studie att ungefär 25 procent

av individer 60 år eller äldre i Europa upplever ensamhet. Vidare visade studien att ensamhet var vanligare i södra och östra Europa, jämfört med norra Europa (Chawla et al., 2021).

2.3 Ofrivillig ensamhet hos äldre

Freedman och Nicolle (2020) beskriver att exempelvis ensamhet, social isolering och social sårbarhet är vanligt förekommande bland äldre och är förknippade med betydande sjuklighet och dödlighet, i nivå med etablerade riskfaktorer såsom rökning, alkoholkonsumtion och fetma. Shankar et al. (2017) beskriver att ensamhet förknippas med ökade svårigheter att genomföra aktiviteter och sysslor i vardagen. I linje med detta visade Lai et al. (2023) i en studie att social isolering var associerad med en ökad risk för att utveckla funktionella nedsättningar, det vill säga försämrad förmåga att självständigt genomföra vardagliga aktiviteter, hos äldre personer. Sambandet var särskilt tydligt bland individer med lägre socioekonomisk status.

Doménech-Abella et al. (2017) fann i en studie olika faktorer som kan kopplas till ensamhet hos äldre. Exempelvis var ensamhet vanligt förekommande hos kvinnor, ensamstående, separerade, änkor, änklingar, boende på landsbygden, individer med färre sociala interaktioner och ett mindre socialt nätverk samt bland de med diagnostiserad depression.

Folkhälsomyndigheten (2024) har identifierat faktorer som har ett tydligt samband med ensamhet för individer som är över 60 år. Dessa är att vara ensamstående, förlust av en partner, ha ett begränsat socialt nätverk, låga nivåer av social aktivitet och självupplevd dålig hälsa samt att vara deprimerad eller ha depressiva symptom. Äldre individer med två eller fler kroniska sjukdomar (multisjuklighet) kan ha en ökad risk för att uppleva ensamhet, antingen i nutid eller vid ett senare tillfälle (Folkhälsomyndigheten, 2024).

Folkhälsomyndigheten (2024) sammanfattade 31 europeiska tvärsnittsstudier kopplade till ensamhet. De fann att cirka en fjärdedel (26 procent) av personer i åldern 60 år och äldre uppger att de upplever måttliga besvär av ensamhet, medan en mindre andel, 8 procent, anger att de har allvarliga besvär. Socialstyrelsen (2022) beskriver att var tionde person över 75 år känner att deras mående påverkas negativt av ensamhet. Kunskapsguiden (2023) redogör för att cirka 10–15 procent av personer i åldern 77 år och äldre uppger att de ofta eller nästan alltid upplever ofrivillig ensamhet. Förutom ålder så kan även att ha en funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig till och umgås med andra personer vara faktorer som ökar risken för att drabbas av ofrivillig ensamhet. Risken att drabbas ökar även ifall individer hamnar i en ny miljö som exempelvis ett särskilt boende, där etablerade sociala kontakter saknas (Kunskapsguiden, 2023).

Samtidigt framhålls att upplevelsen av ensamhet är individuell och komplex, vilket innebär att insatser för att motverka problemet behöver anpassas efter olika behov och kontexter (Fakoya et al., 2020). Fakoya et al. (2020) påpekar även att individualiteten i upplevelsen av ensamhet och social isolering kan medföra svårigheter vid genomförandet av insatser riktade mot äldre. Fakoya et al. (2020) beskriver vidare att det inte enbart finns en lösning för att motverka ensamhet eller social isolering, vilket medför att insatser behöver anpassas. Samtidigt har tidigare forskning visat att vissa typer av insatser kan vara mer effektiva än andra. Cattan et al. (2005) visade att gruppbaserade sociala interventioner, särskilt sådana

som främjar aktivt deltagande och social interaktion, kan vara effektiva i arbetet med att minska ensamhet och social isolering bland äldre. I översikten beskrivs organiserade och strukturerade sociala insatser som centrala komponenter i framgångsrika interventioner. Tanner et al. (2025) beskriver att relationen mellan äldre personer och socialarbetare kan ha betydelse för äldres välbefinnande och upplevelse av stöd. Studien belyser att förtroendefulla relationer, där äldre upplever att de blir lyssnade på och bemötta med förståelse, kan bidra till ökad trygghet och känsla av stöd. Vidare framhålls att kontinuitet i kontakten har betydelse för möjligheten att bygga sådana relationer, eftersom återkommande kontakt kan skapa förutsättningar för tillit och en bättre förståelse för individens behov. Studien beskriver även att personalens roll inte enbart omfattar praktiska eller administrativa insatser, utan även relationsskapande aspekter såsom emotionellt stöd, vägledning och att möjliggöra delaktighet och självbestämmande hos den äldre individen.

2.4 Insatser kopplat till social gemenskap och minskad ofrivillig ensamhet i Sverige

Folkhälsomyndigheten (2024) lyfter fram att det pågår flera initiativ för att minska ensamheten, där det exempelvis finns olika arenor i form av exempelvis mötesplatser för äldre och sociala aktiviteter runt om i landet. Folkhälsomyndigheten (2024) beskriver vidare att arbetet bedrivs av civilsamhället, men även av kommunerna. En utmaning som beskrivs är att många insatser främst når personer som redan är relativt friska och aktiva, medan det är mer utmanande att nå individer som är socialt isolerade eller lever med olika former av ohälsa. I många fall behöver deltagarna själva ha kunskap om att aktiviteterna finns att delta i samt ha möjlighet och mod att ta sig dit (Folkhälsomyndigheten, 2024). Cohn-Schwartz (2020) beskriver att deltagande i sociala sammanhang kan leda till bättre mental hälsa. Lestari et al. (2021) fann i en longitudinell studie av äldre i Europa att socialt deltagande var associerat med bättre fysisk och psykisk livskvalitet bland personer över 75 år, kvinnor och äldre i södra Europa.

2.4.1 Nationell nivå

Folkhälsomyndigheten (2024) beskriver att arbetet kopplat till social gemenskap och minskad ofrivillig ensamhet på nationell nivå huvudsakligen bedrivs av myndigheter och i stor utsträckning styrs av respektive myndighets instruktion och särskilda regeringsuppdrag. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har idag de tydligaste kopplingarna till området, främst genom olika regeringsuppdrag. Tillsammans med ytterligare 24 myndigheter har de tagit fram ett förslag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som innefattar flera aspekter relaterade till ensamhet. Vidare har dessa myndigheter gemensamt haft i uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa under perioden 2020–2023. Övriga myndigheter har i regel mer indirekta kopplingar till ensamhet. Den vanligaste är arbete inom närliggande områden, särskilt frågor som berör delaktighet och inkludering. Andra myndigheter har i stället fokus på forskning och kunskapsutveckling inom området (Folkhälsomyndigheten, 2024).

2.4.2 Regional nivå

På regional nivå bedrivs enligt Folkhälsomyndigheten (2024) både ett folkhälsoinriktat arbete och insatser inom hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten (2024) beskriver vidare att ensamhet ofta utgör en del av regionernas folkhälsoarbete med inriktning mot psykisk hälsa. Flera regioner genomför insatser i syfte att motverka ensamhet, ofta i samverkan med kommunala aktörer och civilsamhället. Ett exempel på detta är att Akademiskt primärvårdscentrum som tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på uppdrag av Region Stockholm har genomfört pilotprojektet *Senior Connect*, med målsättningen att minska social isolering och stödja ett hälsosamt åldrande. Projektet genomfördes vid fyra vårdcentraler, där samtliga personer över 65 år erbjöds att delta i en enkätundersökning som bland annat kartlade upplevd ensamhet. Deltagare som uppgav ensamhet och önskade stöd erbjöds därefter ett strukturerat hälsosamtal och utarbetande av en individuell hälsoplan med fokus på ökad social delaktighet. En utsedd distriktssköterska ansvarade för att koordinera övergången till kommunala och civilsamhällsbaserade aktörer, vilka anpassade sociala aktiviteter utifrån individens intressen och behov. Ett ytterligare exempel på detta är projektet *Social aktivitet på recept* som är ett samarbete mellan Umeå universitet, en lokal hälsocentral och Umeå kommun. Projektets syfte är att förskriva sociala aktiviteter till äldre personer som, vid besök på hälsocentralen, beskriver sig uppleva ensamhet. Förskrivningen av social aktivitet sker utifrån individens specifika behov och intressen, och en aktivitetsansvarig stödjer deltagarna i att hitta och delta i meningsfulla sociala aktiviteter (Folkhälsomyndigheten, 2024).

2.4.3 Kommunal nivå

På kommunal nivå redogör Folkhälsomyndigheten (2024) för att det finns flera verksamheter vars syfte är att främja gemenskap och förebygga ensamhet. Kommunala insatser som syftar specifikt till att förebygga ensamhet och social isolering riktar sig ofta till äldre personer samt till personer med funktionsnedsättningar.

Olika typer av insatser på kommunal nivå som kan nämnas är Örnsköldsvik kommun som samarbetar med Röda Korset för att erbjuda besöksvänner med syfte att minska ensamhet och förebygga psykisk ohälsa. Genom Röda Korsets volontärverksamhet kan äldre personer som upplever ensamhet tilldelas en besöksvän för sällskap och socialt utbyte en till två gånger per månad. Besöken anpassas efter individens behov och önskemål och kan omfatta samtal, promenader eller deltagande i olika aktiviteter. I Upplands Väsby samarbetar kommunen med pensionärsorganisationer och andra ideella föreningar för att erbjuda flera mötesplatser samt en väntjänst. Mötesplatserna erbjuder aktiviteter såsom social gemenskap med fika, underhållning, utflykter och IT-stöd. Väntjänsten arbetar på ett uppsökande sätt för att nå personer i behov av social kontakt. Kommunen driver dessutom en restaurang med subventionerade priser för personer över 65 år. För personer som sörjer en avliden närstående finns möjlighet att fortsatt delta i aktiviteter, som en åtgärd för att motverka ensamhet och social isolering (Folkhälsomyndigheten, 2024).

Ett annat exempel på en kommunal insats för att förebygga ensamhet bland äldre är mötesplatser för äldre och finns inom många kommuner, exempelvis Göteborg stad (u.å.), Uppsala kommun (2026) och Västerås Stad (u.å.) för att nämna några. Antalet mötesplatser inom en kommun varierar också.

Mötesplatser för äldre är en samlingspunkt där besökare kan delta i aktiviteter, fika, läsa tidningen och träffa andra och enligt Västerås stad (u.å.) riktar sig verksamheten till en bred målgrupp. Ofta drivs den i samverkan med olika föreningar och organisationer. Verksamheten omfattar strukturerade aktiviteter och social samvaro med syfte att främja delaktighet och välbefinnande hos deltagarna. Personalen som arbetar på mötesplatserna kan exempelvis vara utbildade som fritidsledare, verksamhetsutvecklare och aktivitetshandledare.

2.5 Teoretiskt perspektiv

Känsla av sammanhang (KASAM) introducerades av Aaron Antonovsky inom ramen för det salutogena perspektivet, som fokuserar på faktorer som främjar och stärker hälsa snarare än orsaker till sjukdom (Antonovsky, 1979). KASAM definieras som en global orientering som uttrycker i vilken utsträckning individen upplever en varaktig känsla av tillit till att stimuli från den inre och yttre miljön är strukturerade, förutsägbara och begripliga, att resurser finns tillgängliga för att möta de krav som ställs samt att dessa krav är värda att engagera sig i (Antonovsky, 1987).

Begreppet KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avser i vilken utsträckning individen upplever sin omvärld som strukturerad och förutsägbar. Hanterbarhet handlar om individens upplevelse av att ha tillgång till resurser, såväl egna som externa, för att möta olika livssituationer. Meningsfullhet betraktas som den motivationsskapande delen och syftar på i vilken grad individen upplever att livets utmaningar är värda att engagera sig i. Vidare betonas att de tre komponenterna i KASAM är nära sammankopplade och samverkar med varandra. Meningsfullhet lyfts ofta fram som den mest centrala komponenten, då den anses vara avgörande för individens motivation att använda sina resurser och hantera olika livssituationer. Begriplighet och hanterbarhet kan därmed ses som förutsättningar för att meningsfullhet ska kunna utvecklas och upprätthållas (Antonovsky, 1987).

2.6 Problemformulering

I takt med att Sveriges befolkning lever allt längre ökar också risken för ofrivillig ensamhet inom målgruppen. Exempelvis beräknas gruppen individer som är 60 år eller äldre uppgå till över tre miljoner år 2032. Med denna utveckling finns en risk att fler äldre kommer att drabbas av ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet bland äldre är en betydande folkhälsoutmaning, då den är kopplad till ökad risk för psykisk ohälsa, nedsatt livskvalitet och somatiska sjukdomar. Att främja social gemenskap utgör därför en viktig hälsofrämjande och förebyggande insats inom folkhälsoarbetet. Samtidigt finns det vetenskapliga kunskapsluckor när det gäller insatser, åtgärder och arbetsmetoder för att förebygga och motverka social isolering och ensamhet. Mötesplatser för äldre är en central arena för att motverka social isolering, men kunskap om hur personalen upplever arbetet med att skapa social gemenskap är begränsad. Genom att undersöka personals upplevelser kan studien bidra med fördjupad förståelse för vilka faktorer som möjliggör eller försvårar ett

hälsofrämjande arbete kopplat till ofrivillig ensamhet, vilket är relevant för utveckling av framtida folkhälsoinsatser. Denna studie syftar därför till att ge en inblick i hur arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre ser ut i praktiken samt bidra med kunskap kring möjliggörande och hindrande faktorer i arbetet.

3 SYFTE

Syftet med studien är att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap.

4 METOD

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av studiens urval och datainsamling. Därefter redogörs för intervjuguidens utformning, samt för utformningen av det tillhörande informationsbrevet. Tillvägagångssättet för analysen beskrivs och metodavsnittet avslutas med att beskriva hur studien har följt forskningsetiska hänsynstaganden.

4.1 Urval

I studien ingår två kommuner, varav en har 14 mötesplatser och den andra 5. De är lokaliserade i olika sociodemografiska områden. Antal anställda varierar från en till fyra på mötesplatserna. I den kommun där majoriteten av informanterna arbetade var fem mötesplatser representerade av totalt 14. I den andra kommunen arbetade personalen på samtliga mötesplatser, olika dagar i veckan. I den kommunen fanns totalt fem mötesplatser där alla var representerade. Studiepopulationen utgjordes av åtta personer som arbetade på olika mötesplatser för äldre inom två kommuner i Mellansverige. Urvalet genomfördes som ett målinriktat, kriteriestyrt urval, vilket enligt Bryman (2021) innebär att informanterna rekryterades utifrån deras relevans i förhållande till studiens syfte. Urvalskriteriet för studien var att informanterna skulle arbeta på en mötesplats för äldre inom en kommun.

En informant rekryterades via ett snöbollsurval, vilket Bryman (2021) beskriver som att studiedeltagare i sin tur rekommenderar andra personer som uppfyller studiens kriterier. Denna informant arbetade på samma mötesplats som en annan informant, som tillfrågade den att delta i studien. I rekryteringen av informanter kontaktades via mejl enhetschefer samt personal på olika mötesplatser för äldre i två kommuner med en förfrågan om intresseanmälan att delta i studien. Vid kontakt med enhetschefer tillfrågades de om de hade någon i sin personalstyrka som var villig att delta i studien. I två fall var enhetschefen även den person som arbetade på mötesplatsen. Vissa mötesplatser hade inte en utnämnd chef på kommunens hemsida att mejla utan en allmän mejladress för hela mötesplatsen eller en

direkt mejladress till personal som arbetade på mötesplatsen. I dessa fall kontaktades mejladresserna och därigenom rekryterades informanter som arbetade som personal på mötesplatserna. Inga påminnelsemejl skickades ut till de som inte besvarat förfrågan. Det fanns fortsatt behov av att få tag på fler informanter efter att samtliga mötesplatser hade tillfrågats i den aktuella kommunen. Därför kontaktades och rekryterades två individer som arbetade som personal på mötesplatser för äldre i en grannkommun för att uppnå målet om åtta informanter. De som var positivt inställda till att bli intervjuade fick ett mejl innehållande informationsbrevet. Var de fortsatt villiga att delta efter att ha läst brevet bokades tid och datum för intervju in. Totalt skickades mejl till elva mejladresser, både privata och allmänna för att få tag på de åtta individer som godkände att delta, vilka därmed utgjorde studiepopulationen.

4.2 Datainsamling

För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod då studiens syfte var att undersöka personals upplevelser av att arbeta för social gemenskap samt minskad ofrivillig ensamhet på mötesplatser för äldre. Fokus i kvalitativa studier ligger i många fall på ord, snarare än på siffror vid insamling och analys av data. Kvalitativ forskning är ofta induktiv, vilket innebär att forskaren utgår från det insamlade materialet och låter mönster, teman eller kategorier växa fram ur empirin (Bryman, 2021).

Datainsamlingsmetoden som användes för att besvara studiens syfte var semistrukturerade intervjuer, som genomfördes individuellt. Denna intervjuform har en styrka i att intervjuaren inte behöva ställa frågorna i intervjuguidens ordning. Det är möjligt att ställa frågorna i den ordning som passar bäst. I intervjuformen ges informanten möjlighet att fritt formulera sina svar. Frågor som inte finns med i intervjuguiden kan även ställas om de anknyter till något som informanten tidigare har uttryckt (Bryman, 2021). Frågorna i intervjuguiden baserades på bakgrundsinformation som identifierats under arbetets gång. Intervjuerna spelades in via en lösenordskyddad mobiltelefon som var satt i flygplansläge och materialet överfördes till en lösenordsskyddad dator. Den kortaste intervjun varade i 25 minuter och den längsta i 42 minuter. Informanterna fick möjligheten att välja om de ville genomföra intervjun fysiskt eller på distans. Fyra av intervjuerna genomfördes fysiskt, tre på den digitala mötesplattformen Teams och en genom Messengers videosamtalsfunktion. Användningen av digitala intervjuer medför enligt Saarijärvi och Bratt (2021) flera fördelar, såsom ökad flexibilitet, minskade kostnader samt möjligheten att inkludera deltagare oberoende av geografisk placering. Samtidigt kan metoden innebära vissa begränsningar, exempelvis svårigheter att etablera en förtroendefull relation mellan intervjuare och deltagare samt en begränsad tillgång till icke-verbal kommunikation, vilket potentiellt kan påverka datakvaliteten (Saarijärvi & Bratt, 2021).

För att säkerställa att deltagarna skulle få information om studiens bakgrund, syfte och målgrupp utarbetades ett skriftligt informationsbrev (Bilaga A). I informationsbrevet tydliggjordes att deltagandet var frivilligt och att informanterna hade möjlighet att avbryta sin medverkan fram till genomförandet av intervjun. Det framgick även att intervjun inte innehöll några frågor som möjliggjorde identifiering av enskilda personer och att det insamlade materialet enbart skulle användas för studiens angivna ändamål. Vidare informerades deltagarna om att datamaterialet skulle raderas efter att studien slutförts och

publicerats. Informationsbrevet innehöll även att den färdiga studien kommer att publiceras i DiVA efter att den är godkänd.

Intervjuguiden (Bilaga B) var semistrukturerad, vilket innebär att den utgår från fördefinierade teman och öppna frågeställningar, samtidigt som den möjliggör flexibilitet i genomförandet genom följdfrågor och anpassning till intervjuns förlopp (Bryman, 2021). Intervjuguiden var utskriven och under intervjuerna antecknades stödord för hand utifrån det som informanterna berättade. I början av intervjuguiden påmindes informanten om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att ange anledning samt att informanten har rätt att avstå att svara på frågor. Därefter tillfrågades informanten om samtycke att delta i intervjun och studiens syfte repeterades. Sedan ställdes frågor samt följdfrågor med relevans för syftet till informanten. Frågorna var indelade i olika teman som exempelvis bakgrund och kontext, arbete i praktiken samt utmaningar. Innan intervjun avslutades sammanfattades stödorden för informanten för att säkerställa att deras upplevelser och erfarenheter uppfattats rätt.

Bryman (2021) beskriver att en pilotstudie är relevant vid semistrukturerade intervjuer. Detta då det är ett bra sätt att testa frågornas ordningsföljd och om frågorna är relevanta och tydliga. En pilotintervju genomfördes med en individ som arbetade på en mötesplats för äldre med syftet att se över frågornas ordningsföljd samt bedöma deras tydlighet och relevans i förhållande till studiens syfte. Pilotstudien bidrog till mindre justeringar inför datainsamlingen. Det som ändrades var att vissa frågor formulerades om så att de blev tydligare.

4.3 Analysmetod

Den valda analysmetoden är manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Metoden är etablerad inom kvalitativ forskning och lämpar sig för analys av intervjutext. En manifest ansats innebär en textnära analys med fokus på det uttryckta innehållet, det vill säga det som framträder tydligt och med ord i materialet. Analysformen karaktäriseras av att forskaren undersöker likheter och skillnader i data, som sedan beskrivs i kategorier eller teman (Graneheim och Lundman, 2017). En ordagrann transkribering av intervjuerna genomfördes i ett Word dokument innan den huvudsakliga analysen påbörjades. I transkriberingen uteslöts dock exempelvis eh, längre pauser och skratt eftersom det inte är relevant i en manifest analys. Totalt utgjorde det transkriberade materialet 52 A4-sidor i Word och totalt 32 135 ord. Teckensnittet som användes var Calibri, storlek elva med enkelt radavstånd. Informanterna namngavs som IF 1 till IF 8 och varje informant tilldelades en färg för att kunna särskilja vem som har sagt vad när exempelvis citat skulle väljas till resultatavsnittet. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes löpande och senast en dag efter att en intervju genomfördes var transkriberingen av den färdig. Detta för att underlätta arbetsprocessen och säkerställa närhet till materialet.

När transkriberingen av intervjuerna var klar lästes materialet igenom flertalet gånger. Detta för att få en helhetsbild av innehållet. Graneheim et al. (2017) betonar vikten av att forskaren fördjupar sin förståelse av materialet för att möjliggöra en tillförlitlig analys. Analysen genomfördes stegvis med stöd av digitala matriser utformade som tabeller i Word (se tabell 1). Inledningsvis identifierades meningsbärande enheter, vilket omfattade ord, meningar

eller textavsnitt med relevans för studiens syfte. För att särskilja de olika informanternas utsagor markerades dessa med olika färger, där varje informant tilldelades en specifik färg. I nästa steg genomfördes en kondensering av materialet, vilket innebar att de meningsbärande enheterna förkortades samtidigt som det centrala innehållet bibehölls. I denna process rensades även talspråk och utfyllnadsord, såsom exempelvis ”liksom” och ”typ”, bort. Efter kondenseringen tilldelades varje enhet en kod, det vill säga en kortfattad benämning som fångade dess huvudsakliga innebörd. Vidare sorterades koderna utifrån liknande innehåll och grupperades i underkategorier. För detta skapades nya matriser i separata Word-dokument, där koder med liknande innehåll samlades för att göra materialet mer överskådligt. Den ursprungliga matrisen användes därmed som utgångspunkt för denna omstrukturering. Analysen resulterade i totalt fem underkategorier och två huvudkategorier. I det avslutande skedet gjordes ytterligare ett urval i materialet, där de mest representativa citaten valdes ut för att presenteras i resultatavsnittet.

Tabell 1: Exempel på analysprocessen.

Meningsbärande enhet	**Kondensering**	**Kod**	**Underkategori**	**Huvudkategori**
Social gemenskap, det kan bara vara att delta i olika aktiviteter, komma hit och sitta ner och prata med varandra, umgås med varandra helt enkelt.	Social gemenskap kan vara att delta i olika aktiviteter, prata och umgås med varandra.	Social gemenskap genom aktiviteter och umgänge	Möjliggörande av social gemenskap	Skapa social interaktion och delaktighet
Ja vi gör väldigt mycket utflykter. Jättemånga. Man sitter bredvid varandra i bussen, man träffar andra, man ser en annan miljö. Vi åker ihop med de andra mötesplatserna	Vi gör väldigt mycket utflykter. Man sitter bredvid varandra i bussen, träffar andra, ser en annan miljö. Vi åker ihop med de andra mötesplatserna	Utflykter skapar sociala möten	Anpassning av aktiviteter	Skapa social interaktion och delaktighet
Men sen tror jag också att fysiska hinder, att man kanske ser och hör dåligt, man kanske har problematiskt att ta sig ur lägenheten, man kanske bor på tredje våningen och måste gå i trappor. Så att	Fysiska begränsningar, som nedsatt syn och hörsel eller svårigheter att ta sig ut från bostaden, kan skapa hinder för deltagande.	Fysiska hinder för deltagande	Fysiska och mentala förmågor	Tillgång till olika resurser

jag tänker att det är kroppsligt som skapar hindren.				
Men att vi som personal är delaktiga är väldigt viktig. Att man inte, det finns ju de grupper som känner varann väldigt väl, då är inte jag så viktig men när det är grupper där de inte känner varann eller det kommer nya då behöver det ju finnas någon med som hjälper dem. Sen ska allt inte hänga på mig men jag brukar tänka att jag för ihop dem och sen när de blir trygga och har varann då kan man backa bak.	Personalens delaktighet är viktig, särskilt i grupper där deltagarna inte känner varandra eller när nya kommer. Då behövs någon som för ihop dem och stöttar tills de blir trygga, därefter kan personalen backa.	Vikten av att personal stödjer nya deltagare	Personalens engagemang	Tillgång till olika resurser

4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden

De forskningsetiska principer som har beaktats i denna studie är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Enligt Bryman (2021) finns det fyra grundläggande etiska principer som bör beaktas inom forskning.

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att besluta om de vill vara med i undersökningen. Detta togs hänsyn till genom att det i informationsbrevet fanns information gällande att deltagandet var frivilligt och att det gick att avbryta sin medverkan utan att ange anledning. Dessutom gavs ett muntligt samtycke i början av intervjun för att säkerställa att informanten hade tagit del av informationen i informationsbrevet.

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Ett informationsbrev distribuerades via mejl till informanterna och innehöll relevant information inför det planerade intervjutillfället. Syftet upprepades även i början av intervjun.

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in endast får användas för forskningsändamålet. Den data som samlats in har enbart använts till denna studie och materialet kommer att raderas efter att studien godkänts av examinator.

Konfidentialitetskravet berör att personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, så att inga obehöriga kan få tag på materialet. Den data som samlades in spelades in med en lösenordskyddad mobiltelefon satt i flygplansläge och förvarades på en lösenordskyddad dator. Informanterna numrerades från IF1 till IF8 för att säkerställa att ingen informants identitet avslöjades.

5 RESULTAT

I detta kapitel presenteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte som var att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap. Resultatet förstärks med citat från informanterna (IF 1 till IF 8). Analysen resulterade i huvudkategorierna ”Skapa social interaktion och delaktighet” och ”Tillgång till olika resurser” med tillhörande underkategorier, se nedan tabell 1.

Tabell 2: Redovisning av resultatets huvudkategorier och underkategorier.

Huvudkategorier	**Underkategorier**
Skapa social interaktion och delaktighet	Möjliggörande av social gemenskap Anpassning av aktiviteter
Tillgång till olika resurser	Personalens engagemang Kunskapskrävande arbete Fysiska och mentala förmågor

5.1 Skapa social interaktion och delaktighet

Huvudkategorin handlar om personalens uppfattningar om mötesplatsers roll i att möjliggöra social interaktion och delaktighet samt att bryta ensamhet hos äldre. Genom mötesplatsen får de äldre möjlighet att träffa nya vänner och delta i aktiviteter tillsammans, vilket enligt informanterna bidrog med positiva effekter för deras psykiska och fysiska hälsa. Huvudkategorin baseras på underkategorierna *möjliggörande av social gemenskap* och *anpassning av aktiviteter*.

5.1.1 Möjliggörande av social gemenskap

Informanterna beskrev att mötesplatsen, som genom att utgöra en plats för sociala möten och skapande av nya vänskaper, bidrog till att bryta ensamhet. Informanterna beskrev att det

var av vikt att de äldre fick chansen att komma ut från sin bostad och vistas i en ny miljö. Detta eftersom det var ett effektivt sätt att bryta ensamhet på.

> ” Det är en man… han kommer hit varje dag … Han växlar några ord och det kan ju räcka för honom. ” (Informant 1)

Enligt informanterna erbjuder mötesplatsen en familjär miljö dit alla är välkomna och uttrycks som ett andra hem och en andra familj. Vidare beskrev informanterna att de i många fall identifierar när besökare inte dyker upp och att de då i många fall brukar ringa hem till individen och fråga hur den mår.

> ” De äldre tycker att det blir som en extra familj de har där de känner sig uppskattade. De kommer och blir saknade om de inte dyker upp. Det är viktigt att ha en plats någonstans där man blir sedd och saknad om man inte kommer. ” (Informant 5)

Att mötesplatsen möjliggjorde för att i grupp samtala om olika ämnen beskrev informanterna var viktigt då dessa samtal möjliggjorde för djupare relationer och samhörighet genom gemensamma intressen eller erfarenheter. Informanterna uppgav ensamhet som ett exempel på ett ämne som bidrog till gemenskap då många av besökarna uttryckte att de antingen känt sig ensamma tidigare eller gjorde det i nuläget. Enligt informanterna hade samtal kring gemensamma intressen en viktig roll i skapandet av social gemenskap och nya relationer.

> ” Ja men i samtalsgrupperna kan det vara fyra, fem personer och så sitter man och diskuterar olika saker. Vi har då en agenda för samtalet och man kanske pratar om barndomen och alla får berätta och man lyssnar in och det som sägs i gruppen hålls där och alla får komma till tals och prata till punkt. ” (Informant 2)

Mötesplatsen kunde enligt informanterna bidra till nya relationer, både på mötesplatsen och utanför den. Informanterna påpekade att många besökare träffat nya vänner genom mötesplatsen som de har kontakt med i vardagen och att de nya relationerna mest troligt aldrig skulle ha skapats om inte mötesplatsen hade funnits. Informanterna har även hört flera exempel på långvariga vänskapsrelationer som skapats genom mötesplatsen som besökare har beskrivit som livsförändrande.

> ” En besökare berättade för mig att hon i helgen haft besök och fikat med två personer som hon lärt känna genom mötesplatsen och när de åkte därifrån så insåg hon efter ett tag att hon inte haft besök på två år och då blev hon glad och alldeles tårögd. ” (Informant 7)

Några informanter påpekade att mötesplatsen möjliggjort social kontakt då de har besökare som annars är väldigt ensamma.

> ” Det är ju många som endast träffar människor när de kommer till oss och som annars bara sitter hemma i sin lägenhet. ” (Informant 6)

Informanterna beskrev att det i många fall var svårast att få individer att komma till mötesplatsen första gången. En informant beskrev att rädsla för utanförskap vid första

besöket var en faktor som kunde bidra till att individer valde att inte komma till mötesplatsen. Vidare beskrev informanterna att det var lättare för besökare att delta flera gånger om de hade varit där förut eftersom de lärt känna både personal och andra besökare och därmed skapat nya kontakter.

> ” En del är rädda för att komma hit för första gången. Kanske kommer någon som är ny och så sitter ett gäng där alla känner varandra och då känner man själv sig utanför. ” (Informant 1)

5.1.2 Anpassning av aktiviteter

Informanterna beskrev att vissa besökare föredrog aktiviteter innehållande fysisk aktivitet i form av exempelvis sittyoga medan andra föredrog att sitta i mötesplatsens café och umgås. Informanterna beskrev att umgås i cafét var särskilt vanligt bland de manliga besökarna och att de i många fall var svårare att få att delta i aktiviteter som var mer fysiskt krävande. Informanterna upplevde att de manliga besökarna fick psykiskt stöd genom fikaträffarna och därmed även bättre psykisk hälsa. Informanterna påpekade att en fördel med mötesplatsen är att det inte finns några tvång och att besökarna själva får bestämma vad de vill göra.

> ” Social gemenskap kan vara vårt café där vi framför allt har väldigt mycket män som sitter hela dagarna där de kommer på morgonen och äter sin frukost, de är lite svårare att få in på aktiviteter som tex gympa men det är en social gemenskap att sitta och prata också. ” (Informant 4)

Informanterna uttryckte att det var viktigt att besökarna själva fick vara med och bestämma vilka aktiviteter som skulle finnas på mötesplatsen samt att aktiviteterna var anpassade så att det fanns något som passade alla besökare. Om besökarna gav förslag på aktiviteter så testades det om de var genomförbara för att sedan utvärderas. Om resultatet var positivt blev det en återkommande aktivitet för besökare att delta i.

> ” … Besökarna själva får gärna komma med önskemål på aktiviteter och det gör de också. Sedan försöker vi implementera förslagen om det är möjligt. ” (Informant 1)

Vidare förklarade informanterna att det fanns scheman där det gick att månadsvis se när aktiviteterna var och vilken tid. Enligt informanterna var detta uppskattat då det blev lättare att hitta information om när aktiviteterna var. Eftersom aktiviteterna var regelbundna kunde det bidra till mer rutin och bättre hälsa i besökarnas vardag. Informanterna påpekade att de som deltog i aktiviteterna i många fall gjorde det regelbundet och att aktiviteterna bidrog till social gemenskap.

> “ Vi har ju ett schema där man tydligt kan se vad som händer och när, och det är många som säger att de uppskattar det. Det blir som en rutin för dem, att komma hit på bestämda tider, och då träffar de också samma personer. Det gör att de fortsätter komma och att det skapas en gemenskap. ” (Informant 2)

Informanterna beskrev en variation av utflykter och resor. Utflykter och kulturupplevelser var återkommande aktiviteter där besökarna deltog tillsammans och som var uppskattade inslag i verksamheten. Informanterna uppgav att dessa aktiviteter lockade deltagare och att

många valde att delta vid flera tillfällen. De beskrev även att aktiviteterna innebar att besökarna kom ut från hemmet, deltog i gemensamma sammanhang och träffade andra personer. I många fall genomfördes utflykterna tillsammans med andra mötesplatser i kommunen.

> ” Ja vi gör väldigt mycket utflykter. Jättemånga. Man sitter bredvid varandra i bussen, man träffar andra, man ser en annan miljö. Vi åkte exempelvis till Bergianska ihop med några av de andra mötesplatserna. ” (Informant 3)

5.2 Tillgång till olika resurser

Huvudkategorin beskriver vikten av engagemang hos personalen, att arbetet är kunskapskrävande samt hur fysiska och mentala förmågor påverkar möjligheten att ta sig till mötesplatsen. Huvudkategorin bygger på underkategorierna *personalens engagemang*, *kunskapskrävande arbete* samt *fysiska och mentala förmågor*.

5.2.1 Personalens engagemang

Informanterna beskrev att engagemang var avgörande för hur effektivt arbetet på mötesplatsen var då arbetet på mötesplatsen i stor utsträckning bestod av att vara närvarande och att aktivt delta i verksamheten. Informanterna framhöll att de ofta rörde sig i lokalen, tog initiativ till samtal och uppmärksammade deltagare som var nya eller som befann sig utanför gemenskapen. Informanterna beskrev även att de i vissa fall deltog i aktiviteter tillsammans med besökarna, vilket kunde bidra till att skapa en mer accepterande och inkluderande miljö. Samtidigt framkom att personalens arbete innefattade att vara lyhörd för deltagarnas behov.

> ” Vi rör oss mycket i lokalen och försöker fånga upp alla, särskilt nya besökare. Ibland är vi med i aktiviteterna också, vilket gör att det blir lättare för deltagarna att slappna av och komma in i gemenskapen.” (Informant 3)

Enligt informanterna gjordes försök att nå äldre som inte besökte mötesplatsen på olika sätt. Ett exempel var att informanterna bad äldre på mötesplatsen, att genom mun-till-mun-metoden nå andra äldre. Informanterna beskrev att metoden innebar att de besökare som varit på mötesplatsen berättade om den på ett positivt sätt samt beskrev vad det gick att göra där för andra äldre. Flera informanter lyfte att deltagare som trivdes på mötesplatsen i vissa fall aktivt uppmuntrade andra att följa med dit, exempelvis genom att erbjuda sällskap första gången. Genom mun-till-mun-metoden beskrev informanterna att många nya besökare tillkommit vilket ytterligare påvisar dess effekt.

> ” Jag tror det bästa sättet att få hit människor, det är genom mun-till-mun-metoden, att de som bor här och besöker oss pratar med grannar och vänner och bjuder hit dem. Det tror jag är bra. ” (Informant 1)

Informanterna beskrev även att de arbetar aktivt utanför mötesplatsen för att nå ut till fler potentiella besökare genom att vara synliga i närområdet.

> “ Alla känner ju inte till mötesplatsen, så vi jobbar aktivt med att sprida information genom affischer i området. ” (Informant 5)

Informanterna uppgav även att de tog kontakt med äldre personer i närområdet, exempelvis i samband med spontana möten, för att informera om verksamheten och vilka aktiviteter som erbjuds. Informanterna beskrev att de arbetar proaktivt för att fånga upp individer som de misstänker är ensamma.

> ”Det är en man som hade en sambo som var mycket här, sen gick hon bort. Jag sprang ut och jagade in honom för jag visste att han hade blivit själv. ” (Informant 1)

En informant beskrev att den hade i uppdrag att genomföra uppsökande hembesök hos personer som fyller 75 år i kommunen för att informera om mötesplatsen och dess syfte. Dessa hembesök gav, enligt informanten möjlighet att nå personer som annars inte hade kännedom om verksamheten, och flera av de besökta individerna valde senare att komma till mötesplatsen.

> ” Jag gör uppsökande besök hos de som fyller 75 i kommunen och där hittar vi väldigt många som inte är delaktiga på något sätt och jag informerar dem om vår verksamhet och vad man kan vara med på. ” (Informant 6)

I många fall beskrev informanterna deras arbete som viktigt och att de var en viktig resurs i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet och främja social gemenskap. Vidare förklarade informanterna att genom att de hade kännedom om de eventuella konsekvenserna av äldres ofrivilliga ensamhet bidrog det till motivation och engagemang på jobbet. En informant nyanserade detta genom att berätta att äldre har berättat att de började dricka alkohol när de kände sig ensamma och att de genom att besöka mötesplatsen slutat dricka och därmed förändrat sina liv.

> ” Vi räddar ju liv varenda dag**.** Många säger ju det att de har tagit till flaskan när de blev ensamma och stängt in sig helt och hållet och genom att ha möjligheten att komma och träffa andra så har de fått ett nytt liv. ” (Informant 8)

5.2.2 Kunskapskrävande arbete

Informanterna beskrev att de hade en viktig roll i att besitta god kännedom om de individer som befann sig på mötesplatsen då de påpekade att de kunde behöva anpassa sitt arbetssätt beroende på om individen var mer extrovert eller introvert. I de fall med mer extroverta besökare beskrev informanterna att de lättare själva tog initiativ och blev en del av gruppen medan de som var mer introverta uppfattades ha svårare med detta. Om besökaren var med introvert valde informanterna att själva introducera deltagaren för de andra besökarna och därmed skapa förutsättningar för social interaktion. Om besökaren var mer extrovert fick istället besökaren själv ta initiativ för att bli en del av gemenskapen. Dock var informanterna alltid beredda att rycka in om de märkte att individen hade svårigheter med detta. I

situationer där det fanns etablerade grupper lyfte informanterna det som särskilt betydelsefullt att personalen fungerade som ett stöd för att inkludera nya deltagare i sammanhanget. Några informanter beskrev, utifrån erfarenhet, vikten av ett bra samarbete och att kunna vara spindeln i nätet.

> ” Det finns ju de grupper som känner varandra väldigt väl, då är inte jag så viktig men när det är grupper där de inte känner varandra eller det kommer nya, då behöver det ju finnas någon med som hjälper till att föra ihop dem. Sen ska inte allt hänga på mig men jag brukar tänka att jag är spindeln i nätet som för ihop dem och sen när de blir trygga och har varandra, då kan jag backa undan. ” (Informant 4)

Enligt informanterna så har de fått erfara hur viktiga anhöriga är. Det kan till exempel handla om att få individer att komma till mötesplatsen där de har rekommenderat släktingar, vänner eller bekanta att ta sig till mötesplatsen. Informanterna beskrev även att anhöriga i vissa fall fungerade som ett stöd i det praktiska kring deltagandet, exempelvis genom att de hjälpte till att uppmärksamma aktiviteter, påminde om tider eller följde med till mötesplatsen vid första tillfället. Vidare menade informanterna att anhöriga ibland tog kontakt med personalen för att få mer information om verksamheten och vilka aktiviteter som erbjuds. Informanterna uppgav att detta kunde underlätta för individen att ta steget till att delta, då informationen först hade förmedlats via någon de redan hade en relation till. Flera informanter beskrev också att anhöriga kunde ha en roll i att uppmuntra till fortsatt deltagande genom att visa intresse för vad som sker på mötesplatsen och prata om aktiviteterna i efterhand.

> ”Jag fick syn på en man som sitter utanför mötesplatsen. Han har bott här i området förut och flyttade tillbaka nu. Han satt mycket ensam hemma och då säger hans dotter åt honom att gå ner till mötesplatsen och det gjorde han. Han är verkligen en i gänget numera. ” (Informant 1)

Informanterna beskrev att sociala medier kunde ha en positiv betydelse för att locka nya besökare till mötesplatsen. Genom att information om verksamheten spreds digitalt kunde anhöriga uppmärksamma mötesplatsen och därefter rekommendera den till äldre släktingar eller vänner. Informanterna uppfattade att detta kunde bidra till ökad kännedom om verksamheten och fungera som en väg in för personer som annars inte själva aktivt hade sökt sig till mötesplatsen.

> ” Dels är det väldigt mycket anhöriga har jag upplevt, att man exempelvis har ett barnbarn som läste om mötesplatsen på Facebook och rekommenderade att man skulle gå hit. Så det är väldigt vanligt. ” (Informant 6)

5.2.3 Fysiska och mentala förmågor

Informanterna beskrev att fysiska faktorer påverkade individers möjlighet till att vara med och delta på mötesplatsen och att det var viktigt att besitta en god fysisk hälsa. Flertalet informanter påpekade att många äldre kan vara drabbade av fysiska hinder som exempelvis gör det svårare att ta sig till mötesplatsen. Exempelvis lyftes svårigheter att gå, dålig hörsel och dålig syn fram som faktorer som kunde försvåra att ta sig till mötesplatsen och delta enligt informanterna. Många informanter ansåg att denna grupp var den svåraste att nå ut till, eftersom de i många fall sitter ensamma hemma och har svårigheter med att ta sig ut från

lägenheten. Några informanter påpekade att detta är en av de grupper som troligen har störst behov av att ta sig till mötesplatsen och träffa andra men att fysiska förmågor kan utgöra ett hinder för detta. Vidare beskrev informanterna vikten av att det fanns mötesplatser i närområdet samt att de äldre hade tillgång till exempelvis färdtjänst eller kollektivtrafik för att ta sig dit.

> ” Sen tror jag också att fysiska hinder kan försvåra. Man kanske ser och hör dåligt, kanske har svårt att ta sig ut ur lägenheten och dessutom bor på tredje våningen. ” (Informant 7)

Enligt informanterna kunde psykiska besvär innebära svårigheter i att få individer att delta. Detta omfattade både de som tidigare hade besökt mötesplatsen och nya individer. Några informanter påpekade att de som var drabbade av psykisk ohälsa i form av exempelvis depression var svårare att få att komma till mötesplatsen. Informanterna beskrev att dessa individer ofta saknade ork eller motivation att lämna hemmet, även om de tidigare hade deltagit i aktiviteter. Vidare framkom att oro, nedstämdhet och en känsla av att inte vilja träffa andra kunde utgöra hinder för deltagande. Flera informanter lyfte också att tröskeln att ta sig till mötesplatsen kunde upplevas som hög, särskilt för nya besökare, och att vissa äldre kunde känna osäkerhet inför att delta i en grupp där de inte kände någon. Informanterna påpekade att det skulle underlätta för de som hade mental ohälsa ifall de exempelvis skulle kunna ha en följeslagare som var med som stöd.

> ” Det är ofta de som mår sämre psykiskt som är svårast att nå. De kan ha varit här tidigare, men tappar orken och blir kvar hemma. Vi märker att det kan finnas en osäkerhet inför att komma hit, särskilt om man inte känner någon sedan innan.” (Informant 8)

6 DISKUSSION

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Syftet med studien var att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap.

6.1 Resultatdiskussion

I följande avsnitt diskuteras uppsatsens huvudsakliga resultat i relation till tidigare forskning och teorin om KASAM. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning samt studiens folkhälsovetenskapliga relevans.

6.1.1 Vikten av att skapa social interaktion och delaktighet

Resultatet visar att skapandet av social interaktion och delaktighet utgör en central del av arbetet på mötesplatser för äldre. Genom gemensamma aktiviteter och sociala sammanhang

ges besökarna möjlighet att etablera och upprätthålla sociala relationer. Det kan dock diskuteras i vilken utsträckning de sociala relationer som skapas inom mötesplatsen består över tid, eller om de främst är knutna till själva verksamheten. I resultatet framkom dock flera exempel på långvariga relationer som har skapats genom mötesplatsen.

Flera studier som Shankar et al. (2017) och Doménech-Abella et al. (2017) visar att social isolering och ensamhet är kopplade till negativa konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa, vilket understryker betydelsen av insatser som främjar socialt deltagande. Resultatet indikerar att social delaktighet inte kan förstås som ett enhetligt fenomen, då deltagarna tycks ha olika behov och preferenser avseende socialt deltagande. Vissa besökare föredrog mer aktiva och fysiska aktiviteter medan andra främst uppskattade möjligheten att sitta i caféet och samtala med andra. Detta kan förstås i relation till Fakoya et al. (2020), som betonar att insatser för att motverka ensamhet behöver individanpassas eftersom upplevelsen av ensamhet och behovet av social kontakt varierar mellan individer. Resultatet kan därmed tolkas som att mötesplatsernas flexibilitet och variation av aktiviteter utgör en viktig förutsättning för att främja delaktighet hos olika grupper av äldre. Resultatet visar även att utflykter och gemensamma aktiviteter upplevdes som betydelsefulla inslag i verksamheten. Tidigare forskning har visat att socialt deltagande är associerat med bättre livskvalitet bland äldre (Lestari et al., 2021). I linje med detta visade de Andrade et al. (2015) att deltagande i sociala och kulturella aktiviteter kunde bidra till ökad socialisering, bättre välbefinnande och högre livskvalitet bland äldre, samt att stöd i att möjliggöra deltagande kan vara betydelsefullt. Utifrån denna studies resultat kan personalens roll därför förstås som central i att skapa de förutsättningar som möjliggör denna typ av gemensamma aktiviteter. Gemensamma upplevelser kan ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv förstås som mer än enbart social samvaro, då de även kan bidra till känslor av tillhörighet och inkludering.
I relation till tidigare forskning kan delaktighet och tillhörighet vara betydelsefullt, eftersom deltagande i sociala sammanhang har kopplats till bättre psykisk hälsa och minskad ensamhet (Cohn-Schwartz, 2020), vilket även har en betydelse för folkhälsan. Utifrån ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1987), kan utflykterna skapa meningsfulla sammanhang och variation i vardagen, vilket potentiellt kan stärka känslan av sammanhang hos deltagarna.

Rapporter från Folkhälsomyndigheten (2024) och Socialstyrelsen (2022) betonar vikten av sociala mötesplatser, där de kan ses som en del av ett förebyggande arbete på samhällsnivå. Även detta visar på kopplingen till folkhälsa. Samtidigt kan det problematiseras att dessa insatser i praktiken främst når de individer som redan har en viss benägenhet och förmåga att ta sig till och delta i sociala sammanhang (Folkhälsomyndigheten 2024), medan de mest isolerade individerna riskerar att fortsatt hamna utanför. I denna studie är det något som belystes då den fann att de individer som besöker mötesplatserna är de som klarar av att ta sig dit medan de som i många fall har störst behov av att vara på mötesplatsen inte kan ta sig dit på grund av exempelvis fysiska eller psykiska hinder. Resultatet kan även förstås i relation till Fakoya et al. (2020), som lyfter att insatser mot ensamhet behöver anpassas efter individers olika behov och livssituationer. Detta kan indikera att platsbundna insatser, såsom mötesplatser för äldre, riskerar att vara mindre tillgängliga för personer med större fysiska eller psykiska hinder.

Vidare framkommer i resultatet att personalens roll är central i att skapa förutsättningar för social interaktion, exempelvis genom att aktivt inkludera deltagare och initiera samtal. Detta kan kopplas till Cattan et al. (2005), som visade att gruppbaserade sociala interventioner som

aktivt främjar social interaktion och deltagande kan vara effektiva i arbetet med att minska ensamhet och social isolering bland äldre. Resultatet i föreliggande studie kan därmed indikera att personalens aktiva arbete med att inkludera deltagare och skapa social kontakt utgör en viktig del i att möjliggöra denna typ av hälsofrämjande sociala sammanhang. Personalens närvaro, stöd och aktiva arbete med att inkludera deltagare kan förstås som faktorer som stärker hanterbarheten, då de utgör en extern resurs som kan underlätta deltagande och minska upplevda hinder. Det kan, i sin tur, kopplas till KASAM:s komponent hanterbarhet då besökare kan uppleva att de har tillgång till stöd, hjälp eller egna förmågor för att klara av svårigheter. Att deltagarna själva får påverka vilka aktiviteter som erbjuds kan förstås som särskilt betydelsefullt ur ett salutogent perspektiv. När aktiviteter utformas utifrån individers egna intressen och önskemål kan deltagandet upplevas som mer meningsfullt, vilket enligt Antonovsky (1987) är centralt för att stärka känslan av sammanhang. Även stöd från anhöriga och andra deltagare kan betraktas som viktiga resurser som stärker hanterbarheten, då de underlättar både praktiska och sociala aspekter av deltagandet. Betydelsen av sociala relationer, exempelvis genom mun-till-mun-spridning, stöd från anhöriga och andra besökare, kan förstås som viktiga resurser som stärker individens hanterbarhet genom att underlätta både praktiska och sociala aspekter av deltagandet. Att få information om verksamheten genom personer som individen redan har en relation till kan även bidra till att sänka tröskeln för att delta och minska osäkerhet inför ett första besök. Denna informationskälla skulle möjligen kunna förstås utifrån att mötesplatserna är belägna i områden med olika socioekonomiska förutsättningar, vilket kan påverka hur tillgänglig information upplevs av olika grupper. För personer med begränsade svenskkunskaper eller annan kulturell bakgrund kan tillgången till information påverkas av språkliga eller kulturella barriärer, vilket potentiellt kan göra personligt förmedlad information mer lättillgänglig än skriftlig information. Hanterbarheten kan även förstås i relation till social sårbarhet, där faktorer såsom språkliga barriärer, begränsad tillgång till information och svagare möjligheter att ta del av samhälleliga resurser kan påverka individers möjligheter till social delaktighet (Mah et al., 2023). Detta kan tolkas utifrån KASAM:s komponent hanterbarhet, då individen genom stöd från omgivningen kan uppleva att det finns resurser tillgängliga för att hantera situationer som annars hade kunnat upplevas som svåra eller osäkra, vilket i sin tur kan kopplas till forskning som betonar betydelsen av stödjande miljöer för att främja social delaktighet (Fakoya et al., 2020; Cohn-Schwartz, 2020). Samtidigt kan ett sådant arbetssätt innebära att deltagandet i viss utsträckning blir beroende av personalens engagemang samt verksamhetens organisatoriska förutsättningar, såsom tid för relationellt arbete. Detta kan förstås i relation till Tanner et al. (2025), som beskriver att förtroendefulla och empatiska relationer mellan äldre personer och personal kan bidra till trygghet, stöd och delaktighet. Studien belyser samtidigt att tidsbrist och administrativa krav kan begränsa möjligheten att bygga och upprätthålla sådana relationer. Detta kan i sin tur påverka i vilken utsträckning mötesplatsen har praktiska förutsättningar att främja social interaktion. Det kan även diskuteras i vilken utsträckning den sociala interaktionen som skapas är tillräcklig i sig, då tidigare forskning visar att kvaliteten i sociala relationer kan vara mer betydelsefull än antalet sociala kontakter (Cohn-Schwartz, 2020).

Resultatet visar även att återkommande aktiviteter och tydliga strukturer bidrar till att skapa kontinuitet och underlätta deltagande. De strukturer som beskrevs inom mötesplatsens verksamhet, såsom tydliga scheman och återkommande aktiviteter, kan bidra till en ökad begriplighet genom att skapa förutsägbarhet i vardagen, vilket kan kopplas till KASAM:s komponent begriplighet. Att aktiviteterna sker regelbundet och vid bestämda tider kan även

bidra till trygghet och igenkänning, vilket kan minska osäkerhet inför deltagande och underlätta för äldre att skapa rutiner i vardagen. Återkommande aktiviteter kan vara särskilt betydelsefullt för individer som tidigare upplevt ensamhet eller social isolering, då regelbundna sociala sammanhang kan skapa en känsla av stabilitet och sammanhang.

6.1.2 Betydelsen av tillgång till olika resurser i arbetet mot ofrivillig ensamhet

Resultatet visar att tillgången till olika resurser utgör en central förutsättning i arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Personalens engagemang, erfarenhet och kunskap framstår som betydelsefulla faktorer för att skapa inkluderande sociala sammanhang och för att nå individer som riskerar social isolering. I denna studies resultat framkom att personalen aktivt arbetade med att introducera nya deltagare, skapa trygghet och få individer att känna sig delaktiga i gemenskapen. Engagemanget kan vara kopplat till kunskap, så som tidigare forskning som visar att social delaktighet och stödjande sociala miljöer kan bidra till bättre psykisk hälsa hos äldre (Cohn-Schwartz, 2020). Ur ett salutogent perspektiv kan personalens stöd förstås som en resurs som stärker individens hanterbarhet, då personalen bidrar till att underlätta socialt deltagande och minska osäkerhet inför nya sociala situationer (Antonovsky, 1987).

Vidare framkommer att personalens relationsskapande engagemang hade stor betydelse för hur inkluderande verksamheten upplevdes vara. Detta kan förstås utifrån Tanner et al. (2025), som beskriver att personalens relationsskapande arbete kan bidra till trygghet, stöd och delaktighet hos äldre personer. I föreliggande studie kan detta relateras till hur personalen genom ett aktivt inkluderande arbetssätt, såsom att introducera nya deltagare i gruppen och underlätta social kontakt, tycktes skapa förutsättningar för social inkludering och etablering av nya relationer. I resultatet framkom att personalen ofta fungerade som "spindeln i nätet" genom att skapa kontakt mellan besökare och aktivt stötta nya individer i att bli en del av gruppen. Detta kan förstås som betydelsefullt då tidigare forskning visat att ensamhet och social isolering ofta är kopplat till begränsade sociala nätverk och svårigheter att etablera nya relationer (Doménech-Abella et al., 2017). Att personalen aktivt arbetade för att minska osäkerhet inför deltagande kan även relateras till Fakoya et al. (2020), som betonar att ensamhet är ett komplext och individuellt fenomen där insatser behöver anpassas efter individers behov och förutsättningar. Genom att personalen hjälper nya deltagare att förstå hur verksamheten fungerar och introducerar dem i gruppen kan verksamheten även bidra till ökad begriplighet, då mötesplatsen blir en tryggare plats för individen. Det kan i sin tur relateras till Antonovsky (1987) teori om Känsla av sammanhang.

Resultatet visade att arbetet på mötesplatsen innefattade ett uppsökande arbetssätt där personalen aktivt försökte nå individer som riskerade social isolering. Exempelvis nämndes hembesök, spontana möten i närområdet och informationsspridning genom affischer och sociala medier. Detta kan förstås i relation till Folkhälsomyndigheten (2024), som beskriver att många insatser mot ensamhet främst når individer som redan är relativt aktiva och socialt delaktiga, medan personer med större behov ofta är svårare att nå. I denna studie, kan det uppsökande arbetet därmed förstås som ett försök att minska dessa hinder och skapa möjligheter för fler äldre att bli delaktiga i sociala sammanhang. Samtidigt kan resultatet indikera att arbetet är resurskrävande och i stor utsträckning beroende av personalens engagemang och initiativförmåga.

Resultatet visar även att arbetet på mötesplatserna är kunskapskrävande och att personalens erfarenheter och deltagarkännedom har stor betydelse för hur verksamheten bedrivs. Anpassning av bemötande beroende på individers personlighet och behov, exempelvis om en individ uppfattades som mer introvert eller extrovert kan tolkas utifrån Fakoya et al. (2020), som beskriver att det inte finns en enskild lösning på ensamhet, utan att insatser behöver individanpassas. Att personalen utvecklat strategier för att introducera nya deltagare och skapa trygghet i gruppen kan även förstås som betydelsefullt för att minska social osäkerhet och främja delaktighet. Samtidigt kan det diskuteras i vilken utsträckning kvaliteten i arbetet blir beroende av personalens individuella erfarenheter och sociala kompetens, då mycket av arbetet verkar bygga på relationsskapande och situationsanpassade bedömningar snarare än tydliga arbetsmodeller. Resultatet kan därmed indikera att arbetet i hög grad blir personbundet, då verksamhetens inkluderande arbete tycks vara beroende av personalens individuella engagemang, initiativförmåga och relationsskapande kompetens. Detta skulle potentiellt kunna medföra skillnader i kvalitet och tillgänglighet mellan olika mötesplatser beroende på personalens erfarenheter och arbetssätt. Samtidigt kan det diskuteras i vilken utsträckning verksamheten har tillräckliga organisatoriska resurser och strukturer för att säkerställa ett långsiktigt och likvärdigt arbete mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Betydelsen av mun-till-mun-metoden och stöd från anhöriga framkom också som centrala resurser för att få äldre att ta steget att delta i verksamheten. Det beskrevs att rekommendationer från andra besökare eller anhöriga ofta upplevdes som mer trovärdiga och trygga än information från personalen. Rekommendationer kan förstås som betydelsefullt då tidigare forskning visat att äldre personer som upplever ensamhet eller psykisk ohälsa kan ha svårigheter att själva söka stöd eller ta initiativ till socialt deltagande (Shankar et al., 2017; Socialstyrelsen, 2022). Anhöriga och andra besökare kan därmed förstås som viktiga resurser som underlättar både praktiska och sociala aspekter av deltagandet.

Vidare visar resultatet att fysiska och psykiska förmågor kan påverka möjligheten att delta i mötesplatsens verksamhet. Det beskrevs att exempelvis nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga och psykisk ohälsa kunde utgöra hinder för deltagande. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att ensamhet hos äldre ofta är kopplad till faktorer såsom försämrad hälsa, funktionsnedsättning och depression (Doménech-Abella et al., 2017; Folkhälsomyndigheten, 2024). Resultatet kan även relateras till Kunskapsguiden (2023), som beskriver att begränsade möjligheter att ta sig ut och delta i sociala sammanhang kan öka risken för ofrivillig ensamhet. Det framkom även i denna studies resultat att de individer som hade störst behov av social gemenskap i många fall också var de svåraste att nå, vilket kan förstås som en central utmaning i arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Detta kan kopplas till Lai et al. (2023), som visade att social isolering var associerad med en ökad risk för försämrad förmåga att självständigt genomföra vardagliga aktiviteter hos äldre. Resultatet i föreliggande studie kan därmed indikera en potentiell negativ spiral, där de individer som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa har svårast att delta i sociala sammanhang också riskerar att påverkas särskilt negativt av fortsatt social isolering.

Att psykisk ohälsa kunde bidra till att individer saknade ork eller motivation att lämna hemmet kan även förstås i relation till forskning som visar att ensamhet och psykisk ohälsa ofta samverkar och förstärker varandra (Shankar et al., 2017; Socialstyrelsen, 2022). Resultatet indikerar därmed att mötesplatsernas arbete inte enbart handlar om att skapa

aktiviteter och sociala sammanhang, utan även om att försöka minska de hinder som försvårar deltagande. Samtidigt kan det diskuteras i vilken utsträckning mötesplatsernas resurser är tillräckliga för att möta behoven hos individer med omfattande fysisk eller psykisk ohälsa, då vissa personer trots verksamhetens stödinsatser fortsatt riskerar att hamna utanför gemenskapen eftersom de exempelvis inte kan ta sig till mötesplatsen.

Möjligheten att känna sig inkluderad, uppskattad och delaktig i ett socialt sammanhang kan bidra till ökad meningsfullhet i vardagen. Detta blir särskilt relevant mot bakgrund av att tidigare forskning visat att en stark känsla av sammanhang är associerad med bättre hälsorelaterad livskvalitet hos äldre (Komeili et al., 2024), vilket kan indikera att faktorer som stärker KASAM även kan ha betydelse för äldre personers välbefinnande. Resultatet kan även förstås som att mötesplatsernas betydelse sträcker sig bortom själva aktiviteterna, då verksamheten även verkar fylla en funktion genom att skapa tillhörighet, vardagsstruktur och känslan av att bli sedd och inkluderad i ett socialt sammanhang. Studiens resultat indikerar att mötesplatsen inte enbart fungerar som en plats för aktivitet, utan även som ett socialt sammanhang där äldre ges möjlighet att upprätthålla relationer och känna gemenskap i vardagen. Detta kan förstås som särskilt betydelsefullt för individer som annars riskerar social isolering och ensamhet. Enligt Antonovsky (1987) är meningsfullhet den motivationsskapande komponenten i KASAM och handlar om att individen upplever att livet och dess sammanhang är värda att engagera sig i. Resultatet kan därmed förstås som att mötesplatsernas sociala sammanhang potentiellt bidrar till att stärka äldre personers känsla av sammanhang genom att erbjuda social gemenskap, stödjande relationer och möjligheter till delaktighet. Samtidigt visar resultaten att tillgången till dessa resurser inte är jämlik för alla äldre, då exempelvis psykisk ohälsa, fysiska begränsningar och social osäkerhet kan påverka möjligheten att ta del av verksamheten. Detta pekar på vikten av fortsatt utveckling av individanpassade och inkluderande arbetssätt inom verksamheter som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Resultatet kan även förstås som att arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre behöver ses som ett långsiktigt och förebyggande arbete, där tidiga insatser och tillgängliga sociala sammanhang kan vara betydelsefulla för att minska risken för social isolering. Mötesplatsernas arbete tycks därmed inte enbart ha betydelse för att bryta redan etablerad ensamhet, utan även för att skapa möjligheter till fortsatt social delaktighet och gemenskap i vardagen. Fynden i studien indikerar att arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre behöver förstås i ett bredare samhälleligt sammanhang, där tillgången till sociala mötesplatser och stödjande insatser kan ha stor betydelse för äldres möjligheter till social delaktighet. De beskrivningar som framkom i resultatet tyder på att mötesplatserna fyller en viktig funktion genom att skapa möjligheter till gemenskap, stöd och social kontakt i vardagen. Detta kan förstås som betydelsefullt ur ett folkhälsoperspektiv, då tidigare forskning och nationella rapporter visat att ensamhet bland äldre kan få konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2024; Socialstyrelsen, 2022).

6.1.3 Framtida forskning

Framtida forskning skulle med fördel kunna fördjupa förståelsen av fenomenet genom att använda en latent kvalitativ innehållsanalys. I föreliggande studie användes en manifest analys med fokus på det explicit uttryckta innehållet i informanternas utsagor. En latent analys hade kunnat bidra till en djupare förståelse av de underliggande meningar, normer och föreställningar som präglar personalens arbete med att motverka ofrivillig ensamhet

bland äldre. Detta hade exempelvis kunnat synliggöra hur ensamhet förstås och konstrueras i praktiken, samt vilka underliggande antaganden som påverkar arbetssätt och bemötande.

Vidare kan framtida forskning använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod för att fånga hur personal gemensamt resonerar kring arbetet med social gemenskap och ofrivillig ensamhet. Eftersom arbetet vid mötesplatser för äldre i hög grad tycks präglas av samspel, erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier hade fokusgrupper kunnat bidra med ytterligare förståelse för hur dessa uppfattningar formas i interaktion med andra. En sådan metod hade även kunnat synliggöra gemensamma normer, organisatoriska förutsättningar och eventuella skillnader i hur arbetet förstås mellan olika verksamheter.

Det skulle även vara värdefullt att framtida forskning undersöker äldre individers egna upplevelser av mötesplatsernas betydelse för social gemenskap och ofrivillig ensamhet. Föreliggande studie har utgått från personalens perspektiv, vilket bidrar med viktig kunskap om hur arbetet bedrivs i praktiken samt vilka möjliggörande och hindrande faktorer som personalen uppfattar i arbetet. Samtidigt kan äldre personers egna erfarenheter bidra med ytterligare förståelse för hur verksamheten faktiskt upplevs av målgruppen, exempelvis avseende känslor av delaktighet, inkludering, tillhörighet och eventuella hinder för deltagande. Ett sådant perspektiv skulle kunna bidra till en mer nyanserad förståelse av mötesplatsernas betydelse och ge ytterligare kunskap om hur verksamheter kan utvecklas för att bättre möta äldre personers behov.

Vidare kan det vara relevant att framtida forskning eftersträvar ett mer heterogent urval av informanter, exempelvis avseende kön. Föreliggande studie inkluderade huvudsakligen kvinnliga informanter, vilket kan ha påverkat de erfarenheter och perspektiv som framkom i materialet. Även om syftet med kvalitativ forskning inte är statistisk generaliserbarhet, skulle ett mer varierat urval kunna bidra till en bredare och mer nyanserad förståelse av hur arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre uppfattas inom olika verksamhetskontexter.

Framtida forskning kan även med fördel använda kvantitativa metoder för att undersöka vilka effekter deltagande i mötesplatser för äldre har på upplevd ensamhet, social delaktighet och psykisk hälsa. Föreliggande studie bygger på personalens upplevelser och erfarenheter av arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet, vilket bidrar med viktig kunskap om hur arbetet uppfattas och bedrivs i praktiken. Samtidigt skulle kvantitativa studier kunna bidra med ytterligare kunskap om i vilken utsträckning deltagande i mötesplatser faktiskt påverkar äldre personers välbefinnande, upplevelse av ensamhet och känsla av social gemenskap. Sådan forskning skulle även kunna möjliggöra jämförelser mellan olika grupper av äldre, exempelvis mellan individer som deltar i mötesplatsers verksamhet och individer som inte gör det, vilket skulle kunna bidra till en ökad förståelse för mötesplatsernas potentiella betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Det finns även ett behov av ytterligare forskning som undersöker mötesplatser för äldres effekter på ensamhet, social gemenskap och hälsorelaterade utfall, för att öka kunskapen om verksamheternas betydelse ur ett folkhälsoperspektiv.

6.1.4 Studiens folkhälsovetenskapliga relevans

Studien är relevant ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv eftersom den belyser ofrivillig ensamhet bland äldre, vilket utgör ett betydande folkhälsoproblem som kan påverka både psykisk och fysisk hälsa samt individers livskvalitet negativt. Social gemenskap, delaktighet och tillgång till stöd kan i detta sammanhang förstås som viktiga hälsofrämjande faktorer, vilket gör det relevant att undersöka insatser som syftar till att främja dessa aspekter. Den föreliggande studien bidrar med kunskap om hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet, vilket kan bidra till en ökad förståelse för hur hälsofrämjande arbete riktat till äldre kan utformas i praktiken.

Studien är även relevant eftersom resultaten belyser både möjligheter och utmaningar i det praktiska folkhälsoarbetet. Resultatet visar att mötesplatser för äldre kan fungera som en betydelsefull hälsofrämjande insats genom att skapa social gemenskap, struktur i vardagen och möjligheter till delaktighet. Samtidigt synliggör studien att de individer som i många fall har störst behov av stöd inte alltid nås av dessa insatser, exempelvis på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, social osäkerhet eller andra hinder för deltagande. Detta aktualiserar frågor om jämlik hälsa, tillgänglighet och hur folkhälsoinsatser kan utvecklas för att bättre nå grupper i utsatta situationer.

Vidare bidrar studien med kunskap om personalens roll i det hälsofrämjande arbetet, där relationsskapande, individanpassning och stöd framstår som centrala komponenter. Kunskapen kan därmed vara värdefull i utvecklingen av framtida folkhälsoinsatser och strategier för att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

6.2 Metoddiskussion

Nedan förs en diskussion kopplad till studiens metodologiska ansats, urval, datainsamling, analysmetod samt kvalitetskriterier.

6.2.1 Urval

Då studiens syfte var att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap valdes en kvalitativ ansats. Då det är särskilt lämplig när syftet är att skapa en fördjupad förståelse för individers upplevelser, erfarenheter och tolkningar av sociala sammanhang (Bryman, 2021), framstår valet av metod som välgrundat för den aktuella studien.

Urvalet i föreliggande studie var ett målstyrt, kriteriestyrt snöbollsurval. Kriteriet för informanterna var att de skulle arbeta på en mötesplats för äldre inom en kommun. En fråga som hade kunnat ställas till informanterna var hur länge de hade arbetat inom området. Detta för att säkerställa att de besatt den erfarenhet som eftersöktes. Dock var detta information som ändå framkom under intervjuerna, där det visade sig att samtliga informanter hade flera års erfarenheter av att arbeta inom mötesplatser för äldre, vilket medförde nyanserade beskrivningar av fenomenet.

Ett målstyrt och kriteriestyrt urval bedömdes som lämpligt för den föreliggande studien, då syftet var att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap. Genom denna urvalsstrategi möjliggjordes rekrytering av informanter som hade direkt erfarenhet av det studerade fenomenet och därmed bedömdes kunna bidra med relevant och innehållsrik information. Detta kan ses som en styrka, då kvalitativ forskning syftar till att skapa en djupare förståelse för specifika erfarenheter och upplevelser snarare än att eftersträva statistisk generaliserbarhet.

Samtidigt kan ett målstyrt urval innebära vissa begränsningar. Eftersom urvalet bygger på forskarens bedömning av vilka deltagare som anses relevanta finns en risk för subjektivitet i urvalsprocessen, vilket potentiellt kan påverka vilka perspektiv som inkluderas i studien. Det kan exempelvis inte uteslutas att informanter med andra erfarenheter hade kunnat bidra med ytterligare perspektiv på det studerade fenomenet. Det kriteriestyrda urvalet innebar dessutom att endast personal som uppfyllde vissa förutbestämda kriterier inkluderades, vilket stärker studiens relevans i relation till syftet, men samtidigt kan ha begränsat variationen i materialet genom att vissa perspektiv exkluderades. Bryman (2021) framhåller att ett målstyrt urval i kvalitativa studier kan innebära en risk för bias, eftersom forskarens egna bedömningar i viss mån kan påverka vilka deltagare som inkluderas. Detta medförde en potentiell snedvridning i den aktuella studien. Samtidigt kan risken för bias minskas genom att analysen genomfördes med ett induktivt angreppssätt samt att urvalet baserades på tydligt formulerade och väl övervägda kriterier (Bryman, 2021), vilket tillämpades i denna studie.

Fördelen med ett snöbollsurval var att studiens författare lättare och mer tidseffektivt kunde nå ut till en individ som en annan informant redan hade en etablerad kontakt med. Urvalet hade dock troligen kunnat bli större om de som inte besvarade mejlet hade fått ett påminnelsemejl. Detta ansågs dock inte nödvändigt eftersom målet med åtta informanter hade uppnåtts genom snöbollsurvalet. Dock kan en nackdel med ett snöbollsurval enligt Bryman (2021) vara att personer tenderar att rekommendera individer med liknande erfarenheter eller perspektiv. Att uppnå mättnad innebär, enligt Bryman (2021), att datainsamlingen kan avslutas när ytterligare intervjuer inte längre tillför ny relevant information, utan i stället bekräftar redan identifierade mönster och teman i materialet. Mättnad ansågs ha uppnåtts då de sista intervjuerna i huvudsak bekräftade tidigare identifierade mönster och återkommande teman, snarare än att tillföra nya perspektiv.

6.2.2 Datainsamling

Datainsamlingen i studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, vilket möjliggjorde en flexibilitet där informanterna gavs utrymme att utveckla sina svar och lyfta aspekter som de själva ansåg vara relevanta. Detta kan ses som en styrka då det bidrog till att generera rika och nyanserade beskrivningar av deras erfarenheter. Spontana följdfrågor kunde också ställas för att fördjupa och nyansera deltagarnas svar, varav denna intervjuform ansågs mest lämplig.

Innan den faktiska datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie där en individ som arbetade på en mötesplats för äldre intervjuades. Detta då det är ett bra sätt att testa frågornas ordningsföljd samt om frågorna är relevanta och tydliga. Efter att pilotstudie genomfördes ändrades uppbyggnaden av vissa frågor för att de skulle bli tydligare. Detta

gjordes eftersom det identifierades som ett hinder i pilotstudien. Dock lades ingen fråga till eller togs bort efter pilotintervjun.

Genom att ljudinspelningarna sparades fanns möjlighet att återkommande ta del av materialet, vilket bidrog till en mer noggrann bearbetning. Transkriberingen möjliggjorde i sin tur att det talade innehållet omvandlades till text, vilket utgjorde ett underlag för vidare analys. Under intervjuerna fördes även stödanteckningar i syfte att säkerställa att informanternas erfarenheter och upplevelser tolkades på ett korrekt sätt.

Inspelningen av intervjuerna kan ha påverkat informanternas benägenhet att uttrycka sig fritt, särskilt om informanterna upplevde frågor som av mer känslig karaktär. Det kan även beaktas att tid och plats för intervjuerna kan ha haft betydelse för datainsamlingen, då en trygg och ostörd miljö kan underlätta för informanterna att dela med sig av sina erfarenheter. I denna studie genomfördes samtliga intervjuer enskilt, antingen i ett enskilt rum eller på distans vilket kan anses ha en positiv påverkan på informanternas känsla av att kunna uttrycka sig fritt. Viktigt att beakta är dock att intervjusituationen i sig kan ha påverkat datainsamlingen, då informanterna kan ha anpassat sina svar utifrån vad de uppfattade som socialt önskvärt eller i relation till intervjuarens önskemål. Detta kan exempelvis vara särskilt relevant då studien berör frågor kopplade till det egna arbetet, där en mer positiv bild av verksamheten kan ha framträtt. Dessutom kan intervjuns längd och upplägg ha påverkat hur utförliga svar som erhölls. Sammantaget har datainsamlingen bidragit till ett rikt empiriskt material, men det är viktigt att beakta de faktorer som kan ha påverkat hur informationen framkommit.

Fyra av de åtta intervjuerna genomfördes digitalt via Teams och Messenger. Att genomföra intervjuer digitalt kan enligt Saarijärvi och Bratt (2021) innebära både styrkor och svagheter. Digitala intervjuer kan innebära flera fördelar, såsom ökad flexibilitet, minskade kostnader och möjlighet att inkludera deltagare oberoende av geografisk plats. Samtidigt kan metoden medföra vissa begränsningar, exempelvis svårigheter att etablera en god relation samt begränsad tillgång till icke-verbal kommunikation, vilket kan påverka datakvaliteten (Saarijärvi & Bratt, 2021). Dock påverkades inte denna studie av nackdelen kopplad till den begränsade tillgången av icke-verbal kommunikation eftersom en manifest analys tillämpades och därmed var enbart det som sades i ord relevant.

6.2.3 Analysmetod

En manifest innehållsanalys bedömdes som lämplig i denna studie då syftet var att beskriva personalens upplevelser av arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en manifest analys är textnära, där analysen fokuserar på det som är direkt uttryckt och tydligt framgår i materialet. Fokus låg därmed i denna studie på att återge informanternas beskrivningar så nära deras egna utsagor som möjligt. Samtidigt kan valet av en manifest analys innebära en begränsning i att mer underliggande betydelser och tolkningar inte i samma utsträckning fångas upp, vilket en latent analys hade kunnat bidra med. Dock ansågs en latent analys, som innebär en djupare tolkning av underliggande meningar, fortfarande mindre relevant i förhållande till studiens syfte efter noggrant övervägande.

Transkriberingen av intervjuerna har kontinuerligt genomförts, senast en dag efter intervjuerna genomfördes eftersom författaren hade intervjuerna färskt i minnet. Därmed minskade risken att viktiga detaljer glömdes bort. Transkriberingen utfördes utan stöd från hjälpverktyg. Bryman (2021) menar att forskaren genom att utföra transkriberingen manuellt kan få en god inblick i datamaterialet.

Enligt Graneheim och Lundman (2017) innebär analysprocessen flera utmaningar. Vid urval och kondensering av meningsbärande enheter finns en risk att nyanser och kontext går förlorade. Vidare innebär kodningen ett tolkningsmoment där forskarens egna bedömningar kan påverka hur materialet förstås. Även kategoriseringsprocessen kan innebära en förenkling av det empiriska materialet, där variation och komplexitet riskerar att reduceras. Dessutom kan det vara utmanande att dra tydliga gränser mellan kategorier, då vissa koder kan vara relevanta inom flera områden. I denna studie har dessa aspekter kontinuerligt beaktats, exempelvis genom att analysen genomfördes stegvis och textnära, i linje med den manifesta analysansatsen. När utmaningar uppstod, såsom svårigheter att dra tydliga gränser mellan koder eller avgöra vilken kategori vissa enheter bäst hörde till, hanterades detta genom att materialet återkommande granskades i relation till studiens syfte och det ursprungliga sammanhanget. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att säkerställa en god förståelse för helheten, och analysmatriser användes för att skapa struktur och transparens i processen. För att ytterligare stärka trovärdigheten valdes representativa citat ut i resultatavsnittet, vilket ger läsaren möjlighet att följa kopplingen mellan det empiriska materialet och de kategorier som identifierades.

Analysprocessen genomfördes med stöd av digitala matriser i form av Word-dokument, vilket möjliggjorde ett flexiblare och mer lätthanterligt material. Användningen av digitala dokument underlättade kontinuerliga revideringar, exempelvis vid omformulering av koder och kategorier under analysens gång. Att lagra materialet digitalt bidrog även till att minska risken för dataförlust, vilket kan vara en nackdel vid arbete med fysiska dokument. Vidare användes en form av färgkodning för att särskilja de olika informanterna i materialet. Detta bidrog till en tydligare struktur i analysarbetet och minskade risken för sammanblandning av utsagor. Färgkodningen underlättade även hanteringen av citat i resultatredovisningen och under analysarbetet, då det möjliggjorde att urskilja varje informant efter en viss färg.

6.2.4 Kvalitetskriterier

Bryman (2021) beskriver att tillförligheten inom kvalitativa studier kan bedömas med hjälp av fyra delkriterier. Dessa är *trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet* och *en möjlighet att styrka och konfirmera*. Dessa kvalitetskriterier har beaktats genom hela forskningsprocessen i syfte att säkerställa en studie med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Enligt Bryman (2021) avser trovärdighet i vilken utsträckning forskningen korrekt återger den sociala verklighet som studeras. I denna studie har detta delkriterium beaktats genom flera åtgärder i datainsamlings- och analysprocessen som syftade till att stärka studiens trovärdighet. I slutet av varje intervju gav intervjuaren en sammanfattning med hjälp av stödord, utifrån det som informanterna berättat. Den semistrukturerade intervjuguiden möjliggjorde även att följdfrågor kunde ställas vid behov, vilket bidrog till att fördjupa och förtydliga informanternas utsagor. Vidare genomfördes en pilotintervju, vilket skapade möjlighet att identifiera otydliga formuleringar och justera intervjuguiden innan

datainsamlingen påbörjades. Intervjumaterialet har transkriberats ord för ord, vilket bidrar till att stärka studiens trovärdighet. Samtliga informanter hade dessutom flera års erfarenhet av arbete vid mötesplatser för äldre, vilket kan antas ha bidragit till rika och välgrundade beskrivningar av fenomenet. Trovärdigheten stärks även av att mättnad bedömdes ha uppnåtts, då återkommande mönster identifierades i de sista intervjuerna och inga nya relevanta perspektiv framkom. I resultatpresentationen har dessutom citat från samtliga informanter inkluderats och fördelats på ett jämnt sätt, vilket möjliggör en bred representation av deras utsagor och bidrar till att deras perspektiv återges på ett nyanserat sätt.

Bryman (2021) beskriver överförbarhet som möjligheten att överföra studiens resultat till andra grupper eller sammanhang. Det är dock i slutändan upp till läsaren att bedöma i vilken utsträckning studiens resultat är överförbara till den egna kontexten. Studiens urval har en god variation i att informanterna arbetar på flera olika mötesplatser inom kommunerna. Dock var endast en informant man, vilket innebär att överförbarheten till män som grupp kan bedömas som låg, om man antar att kön skulle kunna ha en betydelse för studiens resultat. För att höja överförbarheten till gruppen skulle det behövas fler manliga informanter som deltog i studien för att med större säkerhet kunna överföra resultatet till gruppen. Överförbarheten för gruppen kvinnor kan bedömas som hög eftersom majoriteten av informanterna var kvinnor vilket medför att det är lättare att överföra studiens resultat till gruppen kvinnor, jämfört med gruppen män. Orsaken till den stora könsskillnaden var att det var majoriteten kvinnor som arbetade på mötesplatserna och de var dessutom mer villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Överförbarhet har dock inte en lika framträdande roll inom kvalitativ forskning. Enligt Bryman (2021) syftar kvalitativa studier främst till att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen eller en avgränsad grupp, snarare än att generera resultat som kan generaliseras till en bredare population. Denna typ av generaliserbarhet är istället mer central inom kvantitativa forskningsansatser.

Pålitlighet är enligt Bryman (2021) ett granskande delkriterium som avser i vilken utsträckning forskningsprocessen är tydligt och systematiskt beskriven, så att studiens tillvägagångssätt kan följas och förstås av andra. I föreliggande studie har detta beaktats genom att samtliga steg i forskningsprocessen, såsom datainsamling, urval och analys, har redovisats på ett tydligt sätt. Intervjuerna har genomförts och transkriberats noggrant, och analysprocessen har beskrivits för att skapa transparens i hur resultatet har framkommit. En styrka med studien är att den inkluderar både svenska och internationella källor för att påvisa att ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem. Detta är en styrka eftersom det bevisar omfattningen av folkhälsoproblemet.

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman (2021) om forskarens objektivitet. Ett så objektivt förhållningssätt som möjligt har eftersträvats genom hela forskningsprocessen. Samtidigt framhåller Graneheim et al. (2017) att det i kvalitativa studier är svårt att helt undvika egna tolkningar och reflektioner, eftersom forskaren själv analyserar och presenterar materialet. Mot denna bakgrund hade en kvantitativ ansats möjligen kunnat bidra till en mer standardiserad och mindre tolkningsberoende resultatredovisning. Den manifesta analysmetoden kan betraktas som en förstärkande faktor för studiens konfirmerbarhet, då den enligt Graneheim & Lundman (2017) innebär att analysen hålls nära textens synliga innehåll och att forskarens egna tolkningar därmed i möjligaste mån begränsas, vilket ökar möjligheten att följa och granska hur resultaten har framkommit.

6.3 Forskningsetisk diskussion

Bryman (2021) beskriver att det är av vikt att följa forskningsetiska principer vid genomförande av studier. I denna studie har *informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet* tagits i beaktan.

Ett informationsbrev skickades ut till informanterna via mejl som innehöll information om studiens syfte och annan praktisk information som kunde vara bra för informanterna att veta. Detta kan ha påverkat studiens resultat positivt genom att informanterna fick möjlighet att ta del av relevant information i förväg, vilket potentiellt kan ha skapat trygghet och bättre förutsättningar för ett informerat deltagande. Samtidigt kan det inte uteslutas att den information som gavs om studiens syfte kan ha påverkat informanternas svar, då vetskapen om studiens fokusområde möjligen kan ha lett till att de i större utsträckning reflekterade kring vissa aspekter av sitt arbete eller anpassade sina svar utifrån vad de uppfattade som relevant för studien.

I informationsbrevet förtydligades det även att det var frivilligt att delta i studien och att informanterna kunde avbryta sin medverkan utan att ange anledning. I syfte att säkerställa att samtliga informanter hade tagit del av informationen i informationsbrevet inhämtades ett muntligt samtycke i början av intervjuerna i samband med att studiens syfte återupprepades. Samtidigt kan det diskuteras huruvida intervjusituationen i sig kan ha påverkat upplevelsen av frivillighet, då vissa informanter eventuellt kan ha upplevt det som svårt att tacka nej när intervjun väl skulle påbörjas och tid hade avsatts för deltagandet. Detta är en aspekt som bör beaktas utifrån samtyckeskravet, trots att informanterna hade givit muntligt samtycke och fått information om att de kunde avbryta sitt deltagande. En annan aspekt att ta i beaktan utifrån samtyckeskravet är att vissa informanter rekryterades via sina chefer. Detta skulle potentiellt kunna innebära att informanterna känt sig tvingade eller åtminstone känt press att delta eftersom frågan kom från deras chef.

Konfidentialitetskravet har varit en central utgångspunkt i föreliggande studie, vilket innebär att deltagarnas identitet och personuppgifter har hanterats med stor försiktighet. För att säkerställa detta har samtliga informanter avidentifierats i både transkribering och resultatpresentation, vilket innebär att namn och andra identifierbara uppgifter har uteslutits eller förändrats. Trots att konfidentialitetskravet har beaktats genom avidentifiering av informanterna kan en viss risk för igenkänning inte helt uteslutas. Detta gäller särskilt då studien genomförts inom en specifik verksamhet, där antalet anställda är begränsat. Även om namn och direkt identifierande uppgifter har uteslutits kan kombinationen av exempelvis yrkesroll, erfarenheter eller beskrivna situationer i vissa fall göra det möjligt att identifiera enskilda informanter. Detta innebär att konfidentialiteten, trots vidtagna åtgärder, inte kan garanteras fullt ut. Datamaterialet som samlades in via intervjuerna spelades in med en lösenordsskyddad mobiltelefon som var satt i flygplansläge. Inspelningarna fördes därefter över till en lösenordsskyddad dator som enbart forskaren har tillgång till. Nyttjandekravet har i studien tagits i beaktan genom att det insamlade materialet enbart har använts i denna studie och planerar att raderas efter att den är godkänd av examinator. Detta kan ha bidragit positivt till studiens resultat genom att skapa trygghet för informanterna, då vetskapen om att materialet inte skulle användas i andra sammanhang potentiellt kan ha ökat deras benägenhet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Samtidigt kan det inte uteslutas att vissa informanter ändå kan ha varit försiktiga i sina uttalanden, särskilt då

intervjuerna berörde deras yrkesroll och verksamhet, vilket potentiellt kan ha påverkat hur öppet vissa erfarenheter eller kritiska synpunkter uttrycktes.

7 SLUTSATSER.

Personal vid mötesplatser för äldre uppfattar att arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet i hög grad handlar om att skapa inkluderande sociala sammanhang där stöd, relationsskapande och individanpassning är centrala för att möjliggöra delaktighet. Särskilt betydelsefullt framstår personalens aktiva arbete med att introducera nya deltagare, skapa trygghet och sänka trösklar för deltagande.

Samtidigt visar resultaten att arbetet är komplext, då fysisk och psykisk ohälsa, social osäkerhet och praktiska hinder kan begränsa äldre individers möjligheter att delta. Detta innebär att de individer som har störst behov av social gemenskap i vissa fall också kan vara de svåraste att nå, vilket belyser en central utmaning i arbetet mot ofrivillig ensamhet.

Resultaten indikerar även att mötesplatsernas betydelse sträcker sig bortom själva aktiviteterna, då verksamheten kan bidra till tillhörighet, struktur i vardagen och meningsfull social delaktighet. Resultaten kan förstås i relation till Antonovskys (1987) teori om känsla av sammanhang (KASAM), där mötesplatsernas stödjande och sociala sammanhang kan bidra till ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Sammantaget visar studien att mötesplatser för äldre kan utgöra en betydelsefull hälsofrämjande insats i arbetet med att främja social gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Samtidigt pekar resultaten på behovet av fortsatt utveckling av individanpassade, inkluderande och långsiktigt hållbara arbetssätt för att bättre kunna möta äldre personers skiftande behov ur ett folkhälsoperspektiv.

REFERENSLISTA

Antonovsky, A. (1979). *Health, stress, and coping*: *new perspectives on mental and physical well-being*. Jossey-Bass.

Antonovsky, A. (1987). *Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well*. Jossey-Bass.

Bryman, A. (2021). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3 uppl.). Liber.

Cattan, M., White, M., Bond, J., & Learmouth, A. (2005). Preventing social isolation and loneliness among older people: A systematic review of health promotion interventions. *Ageing & Society*, 25(1), 41–67. 10.1017/S0144686X04002594

Chawla K, Kunonga TP, Stow D, Barker R, Craig D, Hanratty B. (2021) Prevalence of loneliness amongst older people in high-income countries: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 16(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255088

Cohn-Schwartz E. (2020). Pathways From Social Activities to Cognitive Functioning: The Role of Physical Activity and Mental Health. *Innovation in aging*, 4(3), igaa015. https://doi.org/10.1093/geroni/igaa015

de Andrade, F. , dos Santos Ferreira, T. , de Oliveira Pereira, D. , Araújo, Í. , de Assunção, J. , Silva, I. , dos Santos Dutra, J. and de Lima Cabral, A. (2015) Senior Citizens' Cultural Activity and Participation in Community Life. *Health*, 7, 859-864. 10.4236/health.2015.77101.

De Jong Gierveld, J. (1987). Developing and testing a model of loneliness. *Journal of Personality and Social Psychology*. 53, 119–128.

Domènech-Abella, J., Lara, E., Rubio-Valera, M., Olaya, B., Moneta, M. V., Rico-Uribe, L. A., Ayuso-Mateos, J. L., Mundó, J., & Haro, J. M. (2017). Loneliness and depression in the elderly: the role of social network. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 52(4), 381–390*. 10.1007/s00127-017-1339-3

Fakoya, O. A., McCorry, N. K., & Donnelly, M. (2020). Loneliness and social isolation interventions for older adults: a scoping review of reviews. *BMC public health, 20(1), 129*. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s12889-020-8251-6

Freedman, A., & Nicolle, J. (2020). Social isolation and loneliness: the new geriatric giants: Approach for primary care. *Canadian family physician Medecin de famille canadien, 66(3), 176–182*. PMC8302356

Folkhälsomyndigheten. (2024). *Ensamhet- förekomst, konsekvenser och åtgärder*. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/09eac2b8b63e4d79a9e1f79dcbc71409/ensamhet-forekomst-konsekvenser-atgarder.pdf

Folkhälsomyndigheten. (2025). *Underlag till nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.* https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2eec2882078d4fe0a5404a30a87aa292/underlag-nationell-strategi-forebygga-motverka-ofrivillig-ensamhet.pdf

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse education today*, *56*, 29–34. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002

Graneheim, U.H, & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:concepts, procedures, and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Göteborg stad. (U.å.). *Mötesplatser för seniorer.* https://goteborg.se/wps/portal/start/uppleva-och-gora/motesplatser/motesplatser-for-seniorer

Komeili, T., Khahan-Yazdi, I., Sadri, M., Shokouhi-Tabar, M., Heidari, M., & Taheri-Kharameh, Z. (2024). Sense of coherence as a protective factor of health-related quality of life in Iranian older adults. *Discov Soc Sci Health 4, 37.* https://doi.org/10.1007/s44155-024-00099-9

Kunskapsguiden. (7 juni 2023). *Om ofrivillig ensamhet bland äldre personer.* https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/ofrivillig-ensamhet-bland-aldre-personer/om-ofrivillig-ensamhet-bland-aldre-personer/

Lai, E. T. C., Ho, S. C., & Woo, J. (2023). Social isolation, socioeconomic status, and development of functional impairments in Chinese older adults aged 70 years and over: a cohort study. *Aging clinical and experimental research,* 35(1), 155–165. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s40520-022-02259-w

Lestari, S. K., de Luna, X., Eriksson, M., Malmberg, G., & Ng, N. (2021). A longitudinal study on social support, social participation, and older Europeans' Quality of life. *SSM - population health,* 13, 100747. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.ssmph.2021.100747

Mah, J. C., Penwarden, J. L., Pott, H., Theou, O., & Andrew, M. K. (2023). Social vulnerability indices: a scoping review. *BMC public health*, 23(1), 1253. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s12889-023-16097-6

Nicholson N. R. (2012). A review of social isolation: an important but underassessed condition in older adults. *The journal of primary prevention,* 33(2-3), 137–152. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s10935-012-0271-2

Regeringskansliet. (30 juni 2025). *WHO lanserar omfattande rapport om ensamhet och social inkludering.* https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2025/06/who-lanserar-omfattanderapport-om-ensamhet-och-social-inkludering/

Saarijärvi, M., & Bratt, E. L. (2021). When face-to-face interviews are not possible: tips and tricks for video, telephone, online chat, and email interviews in qualitative research. *European journal of cardiovascular nursing*, 20(4), 392–396. https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvab038

Shankar, A., McMunn, A., Demakakos, P., Hamer, M., & Steptoe, A. (2017). Social isolation and loneliness: Prospective associations with functional status in older adults. *Health psychology : official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*, *36*(2). 10.1037/hea0000437

Socialstyrelsen. (19 december 2022). *Socialstyrelsen: Så kan äldres ensamhet brytas*. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/socialstyrelsen-sa-kan-aldres-ensamhet-brytas/

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2024). *Insatser för att motverka social isolering och ensamhet i befolkningen*. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/insatser-for-att-motverka-social-isolering-och-ensamhet-i-befolkningen/?pub=107781&lang=sv

Statistiska centralbyrån. (2022). *Efter 60, en beskrivning av äldre i Sverige*. https://www.scb.se/contentassets/c4ac9fb5ad10451aab0885b7160de9b0/be0701_2022a01_br_be51br2202.pdf

Tanner, D., Willis, P., Beedell, P., Nosowska, G., Milne, A., Nelson-Becker, H., & Perry, E. (2025). The contribution of social workers to older people's well-being. *British Journal of Social Work*, 55(6), 2917–2936. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaf080

Uppsala kommun. (10 mars 2026). *Träffpunkter 65+*. https://www.uppsala.se/kultur-idrott-fritid/plats/traffpunkter-65/

Västerås stad. (U.å.). *Mötesplatser för äldre*. https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/aldre/motesplatser-for-aldre.html

World Health Organization. (2025). *From loneliness to social connection*. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/381746/9789240112360-eng.pdf?sequence=1

BILAGA A; INFORMATIONSBREV

Hej!

Jag heter Elias Lång och studerar magisteråret på Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens universitet i Västerås. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete inför min magisterexamen som berör den ökande ofrivilliga ensamheten hos äldre. Syftet med studien är att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap.

Jag önskar nu genomföra intervjuer med personal som arbetar inom mötesplatser för äldre och därför kontaktar jag dig.

Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 minuter och vi kommer tillsammans överens om när och var de ska ske. Deltagande i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange anledning. Inga personuppgifter kommer att samlas in, och ingen information som kan identifiera dig kommer att användas i studien. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Det insamlade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast vara tillgängligt för mig som forskare, min handledare samt examinator. Materialet kommer uteslutande att användas för denna studie och raderas efter att studien har blivit godkänd. Du kommer att ha möjlighet att ta del av den färdigställda rapporten efter att den har godkänts av examinator och publicerats i databasen DiVA.

Om frågor uppstår är det bara att höra av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Tack på förhand!
Vänliga hälsningar,
Elias Lång

Kontaktuppgifter:

Elias Lång

[redacted]

[redacted]

Handledare:

Maria Norfjord van Zyl

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

[redacted]

BILAGA B; INTERVJUGUIDE

Inledning
Innan vi börjar intervjun så vill jag återigen påminna dig om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst utan att ange anledning kan avbryta intervjun. Du har rätt att avstå att svara på frågor som du inte känner dig bekväm på att svara på.

Samtycker du till att delta i intervjun?

Innan jag börjar ställa frågor vill jag kortfattat repetera syftet med min studie, som är att undersöka hur personal vid mötesplatser för äldre uppfattar arbetet kring ofrivillig ensamhet och social gemenskap.

Jag kommer att skriva ner stödord under intervjuns gång. Sedan kommer jag i slutet av intervjun sammanfatta dessa för att se om jag uppfattat er rätt.

Bakgrund och kontext

Kan du berätta om din roll här på mötesplatsen?

Hur länge har du arbetat här på mötesplatsen?

Hur skulle du beskriva mötesplatsens syfte och uppdrag?

Vad innebär social gemenskap för dig?

Arbetet i praktiken

Hur upplever du att mötesplatsen påverkar de äldres hälsa?

Hur tänker du kring mötesplatsens roll i att minska ofrivillig ensamhet bland äldre?
Märker du av ofrivillig ensamhet i praktiken och i så fall hur?

Hur arbetar ni konkret för att främja social gemenskap?

Kan du beskriva en situation där du upplevde att ni lyckades skapa social gemenskap på mötesplatsen?

Finns det särskilda aktiviteter eller arbetssätt som du upplever fungerar särskilt bra för att stärka den sociala gemenskapen?

Vad upplever du är viktigt när du arbetar med att öka den sociala gemenskapen?

Har ni några riktlinjer för att öka social gemenskap och minska ofrivillig ensamhet?

Utmaningar

En utmaning kan vara att det är svårt att nå alla äldre, där det kan finnas olika anledningar till att de inte kommer till mötesplatsen. Hur arbetar ni med att nå ut till äldre och få de att komma till mötesplatsen?

Finns det grupper av äldre som du uppfattar är svårare att nå? Vad anser du att det kan bero på?

Vilka utmaningar möter du i mötesplatsens arbete med att minska ofrivillig ensamhet?

Hur påverkar organisatoriska faktorer (till exempel resurser, tid, bemanning) ert arbete?

Möjligheter

Vilka möjligheter har mötesplatsen för att påverka social gemenskap och ofrivillig ensamhet bland de äldre? (Tex kompetens, bemötande)

Utveckling

Vad skulle behövas för att ytterligare stärka arbetet mot ofrivillig ensamhet?

Avslutande frågor

Om du med dina erfarenheter skulle ge råd till någon som startar en ny mötesplats för äldre, Vad är viktigast att tänka på för att öka social gemenskap och minska ofrivillig ensamhet?

Finns det något du tycker är viktigt att lyfta som vi inte har pratat om?

Sammanfatta respondenten i slutet. Fråga därefter om jag har uppfattat er rätt?


Mälardalens
universitet